AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

OBSTETRICIA

Medicina Materno-Fetal

21 temas · 1 página cada uno · **7** días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Control Prenatal & Evaluación Fetal

★★★ 19.1. Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre 3
★☆☆ 19.2. Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría) 4
★★☆ 19.3. Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal 5
★★☆ 19.4. Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler 6

02 Patologías Médicas del Embarazo

★★☆ 19.5. Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad 7
★★☆ 19.6. Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio 8
★☆☆ 19.7. Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia 9
★☆☆ 19.8. Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico 10
★★★ 19.9. Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda 11
★☆☆ 19.21. Cardiopatía, Embarazo Múltiple e Hiperemesis Gravídica: Riesgo Materno, Corionicidad y Manejo Inicial 12

03 Metrorragias de la Primera y Segunda Mitad del Embarazo

★★★ 19.10. Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030 13
★★★ 19.11. Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico 14
★☆☆ 19.12. Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento 15
★★★ 19.13. Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa 16

04 Parto Prematuro, Mecanismo del Parto, Puerperio & Urgencias Obstétricas

★★☆ 19.14. Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis 18
★★★ 19.15. Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección GES 19
★☆☆ 19.16. Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento GES 20
★★★ 19.17. Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO) 21
★★☆ 19.18. Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado 22
★★☆ 19.19. Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso) 23
★☆☆ 19.20. Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada 24

Números que tienes que saber 25
Fármacos de primera línea 28
GES de la especialidad 28
Plan de repaso de 7 días 29
Índice por prioridad ★ 30

BLOQUE 01 · CONTROL PRENATAL & EVALUACIÓN FETAL

19.1 Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre

★★★ PRIORIDAD ALTA
17 preguntas reales 2013–2025

3.01.3.001 Control prenatal — Conocimiento general

También: Determinación de edad gestacional · Anemia y embarazo

LO QUE TE PREGUNTAN

- El ácido fólico en dosis de **0.4 mg**/día se prescribe periconcepcional hasta las **12 semanas** (**5 mg**/día en alto riesgo DTN).
- El carbonato de calcio (**1.000-1.500 mg**/día) se inicia a las **12-16 semanas** para prevención de preeclampsia.
- La ecografía del primer trimestre (LCN) es el método más preciso para fechar la gestación (margen error **± 3-5 días**).
- Glicemia en ayunas en 1.er trimestre **≥ 100-125 mg/dL** en dos ocasiones define Diabetes Gestacional precoz.
- La PTGO con **75 g** se realiza universalmente entre las semanas 24 y 28 (glicemia **2h ≥ 140 mg/dL** es diagnóstica).

ALGORITMO · CONTROL PRENATAL: SUPLEMENTACIÓN Y BATERÍA DE EXÁMENES

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

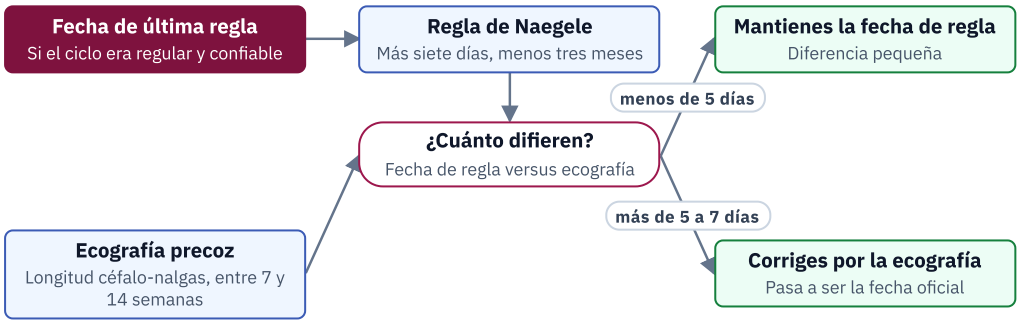


TABLA 19.1 · BATERÍA OFICIAL DE EXÁMENES EN EL CONTROL PRENATAL (GUÍA PERINATAL MINSAL)

TRIMESTRE / SEMANA	EXÁMENES OBLIGATORIOS	OBJETIVO CLÍNICO / DIAGNÓSTICO	CONDUCTA ANTE ALTERACIÓN
Ingreso (< 12 sem)	Grupo/Rh, Coombs ind, VDRL, VIH, Glicemia, Urocultivo, Chagas	Línea base, despistaje de ITS e ITU asintomática	Tratar según patología (ej. Penicilina en sífilis)
11 a 14 sem	Ecografía de 1.er Trimestre	Aneuploidías (Translucencia Nucal) + Doppler uterinas	Cálculo de riesgo de preeclampsia / Trisomías
20 a 24 sem	Ecografía Morfológica + Cervicometría	Anatomía fetal detallada + riesgo parto prematuro	Pesquisa malformaciones / Progesterona si cérvix < 25mm
24 a 28 sem	PTGO 75g (Glicemia basal y 2 horas)	Tamizaje universal de Diabetes Gestacional	Glicemia 2h ≥ 140 mg/dL = Dieta e insulina
28 sem	Coombs indirecto + Profilaxis Anti-D	Madres Rh(-) no sensibilizadas (Coombs negativo)	Administrar Inmunoglobulina Anti-D 300 mcg IM
35 a 37 sem	Cultivo Vaginorrectal para EGB	Colonización por Streptococcus agalactiae	Penicilina G EV intraparto (5 mill inicial + 2.5 mill c/4h)

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Alto riesgo de defecto del tubo neural	Ácido fólico 4 a 5 mg desde 3 meses antes	Dejarla con 0,4 mg, como si fuera bajo riesgo
FUM y ecografía difieren más de 5 a 7 días	Corregir la edad gestacional por la ecografía	Mantener la fecha de última regla
Glicemia de ayuno entre 100 y 125	Repetir la glicemia de ayuno	Pedir la PTGO de inmediato

REGLA DE ORO **Diferencia mayor a 5-7 días** — Corrige por la ecografía precoz

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **1–4** (pág. 8) · solucionario pág. 22.

Clase 19.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · CONTROL PRENATAL & EVALUACIÓN FETAL

19.2 Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
7 preguntas reales 2013–2025

3.01.4.003 Ecotomografía obstétrica normal — Emplea informe

También: Ecotomografía obstétrica patológica · Doppler materno-fetal · Embarazo con edad gestacional dudosa · Amniocentesis

LO QUE TE PREGUNTAN

- La ecografía 11-14 sem evalúa la Translucencia Nucal (patológica **≥ 3 mm**) y Doppler de arterias uterinas.
- Doppler de uterinas alterado (> P95) es indicación de Aspirina **150 mg**/noche antes de la semana 16.
- La Aspirina iniciada precozmente reduce drásticamente la preeclampsia prematura (< **34 semanas**).
- La ecografía 20-24 sem realiza el estudio anatómico morfológico fetal y la cervicometría transvaginal.
- Cuello uterino corto (< **25 mm**) antes de las **24 semanas** es indicación de Progesterona vaginal **200 mg**/noche.



LONGITUD CÉFALO-NALGAS
Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 117

ALGORITMO · LAS DOS ECOGRAFÍAS UNIVERSALES DEL EMBARAZO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 19.2 · COMPARACIÓN DE LAS DOS ECOGRAFÍAS UNIVERSALES CLAVE DEL EMBARAZO

PARÁMETRO	ECOGRAFÍA DE 11 A 13+6 SEMANAS	ECOGRAFÍA DE 20 A 24 SEMANAS
Vía de Examen	Abdominal y/o Transvaginal	Abdominal + Transvaginal (cérvix)
Objetivo Fetal	Aneuploidías (TN, Hueso nasal, Ductus)	Anatomía de órganos y malformaciones
Objetivo Materno	Doppler uterinas (Riesgo preeclampsia)	Cervicometría (Riesgo parto prematuro)
Marcador Patológico	TN ≥ 3 mm / IP uterinas > P95	Malformación / Cuello uterino < 25 mm
Intervención Terapéutica	Aspirina 150 mg/noche (si Doppler alterado)	Progesterona vaginal 200 mg/noche (cuello corto)

TRAMPAS EUNACOM

HALLAZGO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Translucencia nucal ≥ 3 mm	Estudio genético invasivo	Repetir la ecografía en unas semanas
Doppler de uterinas alterado	Aspirina antes de la semana 16	Iniciar aspirina después de la semana 20
Cuello menor a 25 mm, sin antecedentes	Progesterona vaginal hasta la semana 36	Indicar cerclaje de entrada

REGLA DE ORO **Translucencia alterada** — Riesgo del feto: estudio genético

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **5–6** (pág. 8) · solucionario págs. 22–23.

Clase 19.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · CONTROL PRENATAL & EVALUACIÓN FETAL

19.3 Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
8 preguntas reales 2013–2025

3.01.5.009 Monitorizacion fetal (estresante y no estresante) — Realizar

También: Perfil biofisico fetal · Evaluación anteparto

LO QUE TE PREGUNTAN

- **RBNE Reactivo**: **≥ 2 aceleraciones** (aumento **≥ 15 lpm** por **≥ 15 seg**) en **20 minutos** con FCF 110-160 y variabilidad 6-25.
- La causa benigna más frecuente de RBNE no reactivo es el ciclo de sueño profundo fetal (dura **20-40 min**).
- Perfil Biofísico de Manning evalúa 5 parámetros (cada uno 2 puntos): RBNE, respiración, movimientos, tono y líquido amniótico.
- Un PBF de 10/10 u 8/10 con líquido normal indica ausencia de asfixia fetal.
- Un PBF **≤ 4**/10 indica asfixia fetal severa e interrupción inmediata del embarazo.
- El oligohidramnios (bolsillo vertical < **2 cm**) es un marcador de hipoperfusión renal fetal crónica.



REGISTRO CARDIOTOCOGRÁFICO
Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 171

ALGORITMO · CÓMO SE LEE UN REGISTRO BASAL NO ESTRESANTE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

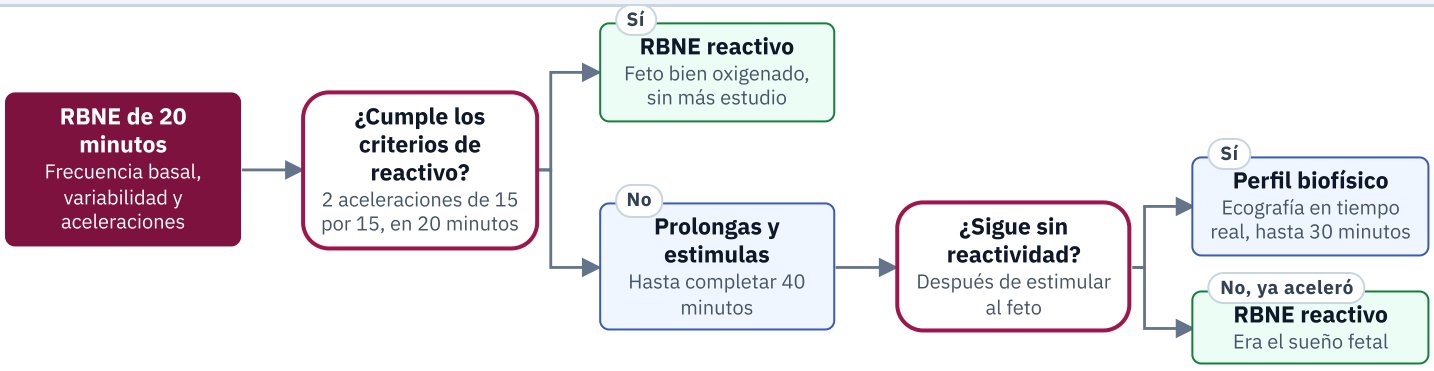


TABLA 19.3 · SCORE DE PERFIL BIOFÍSICO FETAL DE MANNING (CRITERIOS ECOGRÁFICOS Y DE MONITOREO)

VARIABLE BIOFÍSICA	CRITERIO NORMAL (2 PUNTOS)	CRITERIO ANORMAL (0 PUNTOS)	CENTRO NEUROLÓGICO REGULADOR
Movimientos Respiratorios	≥ 1 episodio de ≥ 30 segundos en 30 min	Ausentes o < 30 segundos de duración	Centro respiratorio del bulbo (sensible a hipoxia)
Movimientos Corporales	≥ 3 movimientos gruesos de cuerpo/miembros	< 3 movimientos en 30 minutos	Corteza cerebral y núcleos motores
Tono Muscular Fetal	≥ 1 flexión activa con retorno elástico	Extensión lenta sin flexión o flacidez	Corteza motora subcortical (el más resistente)
Reactividad FCF (RBNE)	≥ 2 aceleraciones de ≥ 15 lpm x 15 seg	< 2 aceleraciones en 40 minutos	Hipotálamo y sistema nervioso autónomo
Líquido Amniótico	Bolsillo vertical único ≥ 2 cm (ILA 5-24)	Bolsillo máximo < 2 cm (Oligohidramnios)	Perfusión renal fetal (reflejo de hipoxia crónica)

TRAMPAS EUNACOM

SITUACIÓN	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
RBNE sin aceleraciones a los 20 minutos	Prolongar y estimular hasta los 40 minutos	Concluir sufrimiento fetal de inmediato
RBNE no reactivo tras 40 minutos	Perfil biofísico o Doppler	Interrumpir el embarazo sin más estudio
Perfil biofísico 8/10 con oligohidramnios	Marcador de hipoxia crónica	Tranquilizarse porque el puntaje es alto

REGLA DE ORO **2 aceleraciones de 15 por 15** — En 20 minutos: reactivo

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **7–8** (pág. 9) · solucionario pág. 23.

Clase 19.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · CONTROL PRENATAL & EVALUACIÓN FETAL

19.4 Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

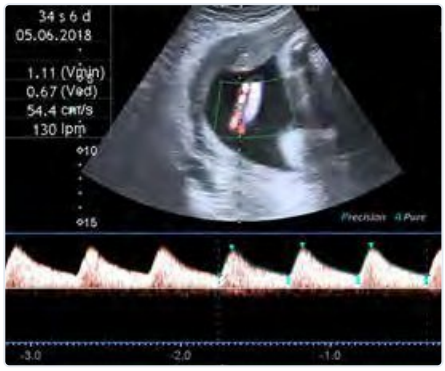
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
12 preguntas reales 2013–2025

3.01.1.010 **Restricción de crecimiento fetal** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Doppler materno-fetal · Ecotomografía obstétrica patológica

LO QUE TE PREGUNTAN

- **PEG constitucional**: EPF entre P3 y P10 con Doppler rigurosamente normal (pronóstico excelente).
- **RCF patológico**: EPF < P3, o EPF P3-P10 con Doppler patológico, o caída de 2 canales percentilares.
- **RCF precoz (< 32 sem)**: Asociado a preeclampsia y placentación defectuosa con deterioro Doppler progresivo.
- **RCF tardío (≥ 32 sem)**: Asociado a vasodilatación cerebral (ACM < P5) y riesgo de hipoxia súbita intraparto.
- Etapa I (Doppler umbilical > P95 o ACM < P5) se interrumpe a la semana 37.



UMBILICAL NORMAL
Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 121

ALGORITMO · PEG CONSTITUCIONAL VERSUS RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO FETAL

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

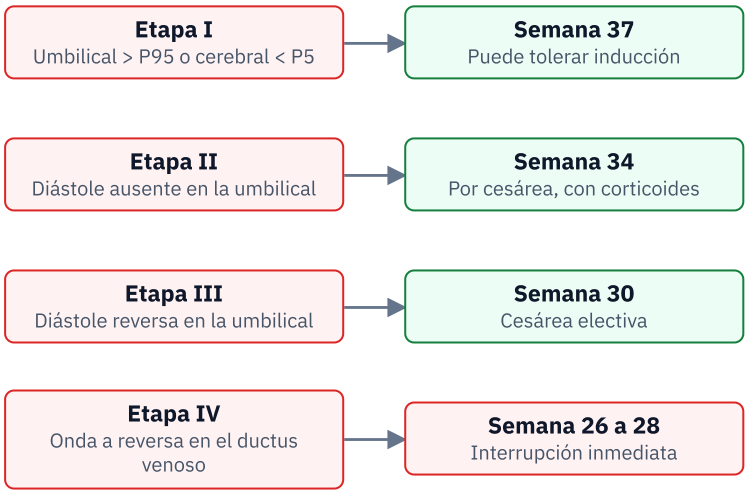


TABLA 19.4 · DIFERENCIAS CARDINALES ENTRE PEG CONSTITUCIONAL Y RCF PATOLÓGICO

CARACTERÍSTICA	PEQUEÑO PARA EG CONSTITUCIONAL (PEG)	RESTRICCIÓN CRECIMIENTO FETAL (RCF)
Percentil de Peso (EPF)	Percentil 3 a 10	< P3 o P3-P10 con Doppler alterado
Velocimetría Doppler	Estrictamente normal en todos los vasos	Patológico (Umbilical > P95, ACM < P5, etc.)
Líquido Amniótico	Normal (ILA 5 a 24 cm)	Frecuentemente oligohidramnios
Monitoreo Cardiofetal	Reactivo con buena variabilidad	Desaceleraciones / Pérdida de variabilidad
Asociación con Preeclampsia	Nula	Muy alta (especialmente en RCF precoz)
Momento del Parto	Término espontáneo (39 a 40 semanas)	Interrupción programada según etapa Doppler

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Percentil 3 a 10, Doppler normal	PEG constitucional: parto a término	Adelantar el parto por el peso solo
Menor a percentil 3, aunque el Doppler mejore	Restricción de crecimiento severa: cesárea	Esperar porque el Doppler se ve normal ahora
Diástole ausente en la arteria umbilical	Interrumpir a la semana 34, por cesárea	Solo repetir el Doppler y observar

REGLA DE ORO **P3 a P10, Doppler normal** — PEG: parto a término

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **9–18** (págs. 9–10) · solucionario págs. 23–25.

Clase 19.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO

19.5 Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
11 preguntas reales 2013–2025

3.01.1.011 Síndrome hipertensivo del embarazo — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Pre eclampsia · Función renal en el embarazo

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Hipertensión en el embarazo**: PA sistólica **≥ 140 mmHg** y/o diastólica **≥ 90 mmHg**.
- **HTA crónica**: diagnosticada antes de la semana 20 de gestación o previa al embarazo.
- **Preeclampsia**: hipertensión que aparece después de la semana 20 asociada a proteinuria (**≥ 300 mg/24h**).
- **Antihipertensivos de 1.ª línea orales seguros**: Labetalol, Alfa-metildopa y Nifedipino.
- ¡IECA (Enalapril) y ARA-II (Losartán) están ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS por daño renal fetal!
- La preeclampsia sin criterios de severidad se interrumpe de forma programada a las **37 semanas**.

ALGORITMO · TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO: CLASIFICACIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

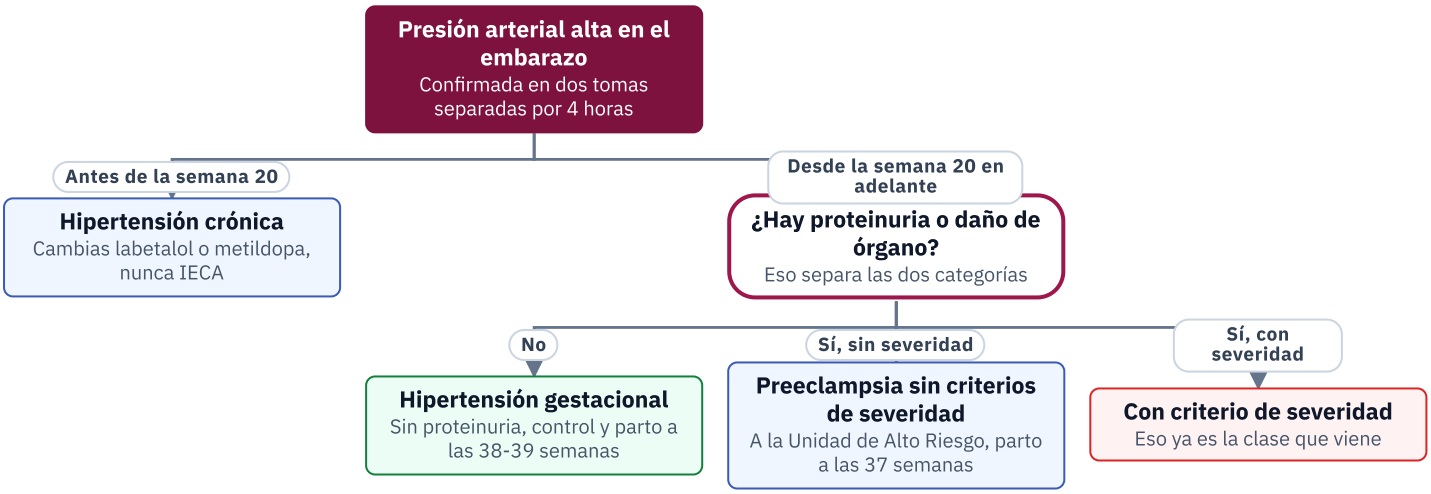


TABLA 19.5 · CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO

CATEGORÍA CLÍNICA	MOMENTO DE APARICIÓN	PRESENCIA DE PROTEINURIA	RESOLUCIÓN POSTPARTO
Hipertensión Crónica	Antes de semana 20 (o previa)	Ausente (salvo nefropatía basal)	Persiste más allá de 12 semanas postparto
Hipertensión Gestacional	Semana 20 o posterior	Ausente (< 300 mg/24h)	Se normaliza antes de 12 semanas postparto
Preeclampsia sin Severidad	Semana 20 o posterior	Presente (≥ 300 mg/24h o IPC ≥ 0.3)	Se normaliza en el puerperio
Preeclampsia con Severidad	Semana 20 o posterior	Presente o Daño de Órgano Blanco	Riesgo materno grave · Requiere interrupción
HTA Crónica + Preeclampsia	Hipertensión previa a sem 20	Aparición de novo de proteinuria > 20 sem	Empeoramiento agudo del pronóstico

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
PA alta, proteinuria justo bajo 300 mg	Antihipertensivo oral, sin llamarla preeclampsia	Diagnosticar preeclampsia igual
Embarazada con creatinina de 1,0 mg/dL	Anormal: estudiar la función renal	Creerla normal por estar en rango adulto

REGLA DE ORO **Antes de la semana 20** — Es hipertensión crónica

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **20–22** (pág. 10) · solucionario pág. 25.

Clase 19.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO

19.6 Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
12 preguntas reales 2013–2025

3.01.2.004 Eclampsia — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Crisis hipertensiva del embarazo · Síndrome hipertensivo del embarazo

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Preeclampsia severa**: PA **≥ 160**/110, plaquetas < 100.000, transaminasas elevadas x2, creatinina > 1.1 o epigastralgia.
- **Eclampsia**: Convulsiones tónico-clónicas generalizadas en una paciente con preeclampsia.
- El Sulfato de Magnesio es el fármaco de elección para prevenir y tratar la eclampsia (muy superior a benzodiacepinas).
- **Dosis de Sulfato de Magnesio**: Carga de **4-5 g** EV en **20 min**, luego mantención de **1-2 g**/h en BIC x **24h** postparto.
- **Monitoreo estricto de magnesemia clínica**: Reflejo rotuliano presente, FR **≥ 12 rpm** y diuresis **≥ 30 mL/h**.
- El antídoto de la intoxicación por sulfato de magnesio es el Gluconato de Calcio al **10%** (**1 g** EV lento).

ALGORITMO · EMERGENCIA HIPERTENSIVA: EL ORDEN DE ACCIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

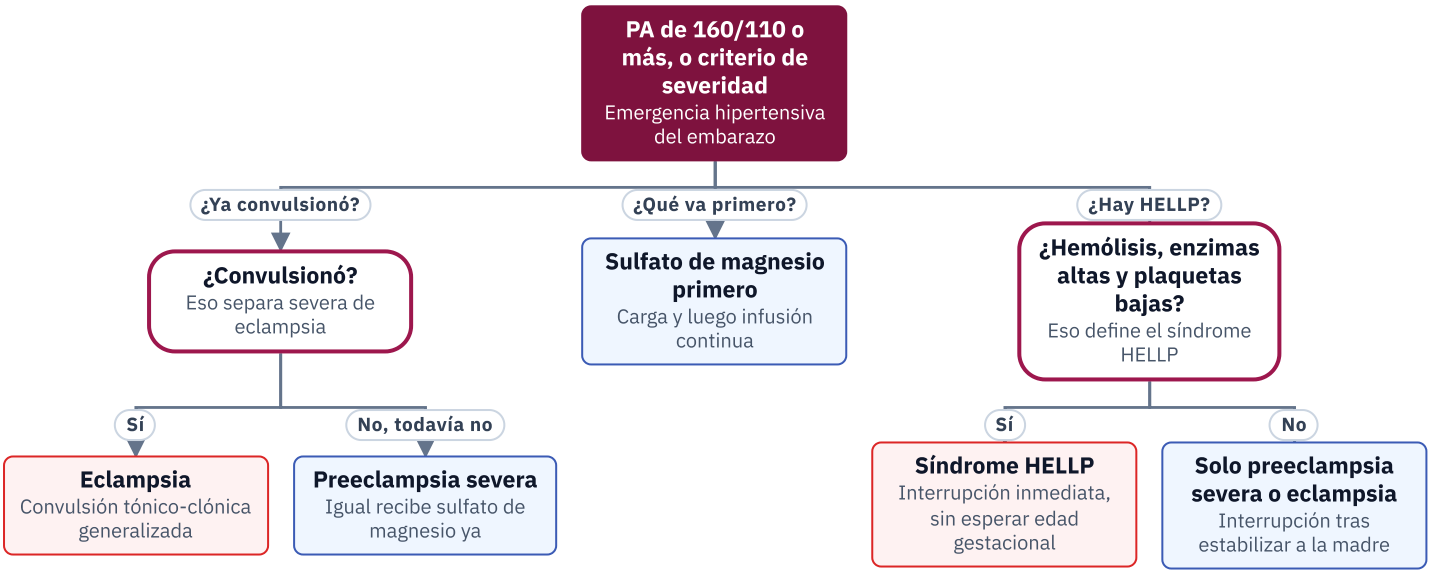


TABLA 19.6 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL SÍNDROME HELLP (CRITERIOS DE TENNESSEE)

COMPONENTE HELLP	PARÁMETRO DE LABORATORIO	VALOR DE CORTE DIAGNÓSTICO	RIESGO CLÍNICO
H - Hemólisis Microangiopática	LDH sérica / Bilirrubina / Frotis	LDH > 600 U/L · BT ≥ 1.2 mg/dL · Esquistocitos	Anemia aguda severa, hemoglobinuria
EL - Elevación Enzimas Hepáticas	Transaminasas séricas (AST/GOT)	AST ≥ 70 U/L (o doble del valor normal)	Hematoma subcapsular hepático, necrosis
LP - Trombocitopenia (Plaquetas)	Recuento de plaquetas en sangre	Plaquetas < 100.000 / mm³	Coagulopatía, CID, hemorragia postparto

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Preeclampsia severa, aún sin convulsionar	Sulfato de magnesio de todas formas	Esperar a que convulsione para darlo
Convulsión activa, con antecedente de epilepsia	Sulfato de magnesio, no antiepilépticos	Tratarla como una crisis epiléptica
Presión ya controlada, pero convulsiona después	Igual es sulfato de magnesio, no otro antihipertensivo	Solo subir la dosis del antihipertensivo

REGLA DE ORO **Primero sulfato de magnesio** — Antes que la presión o el parto

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **23–28** (pág. 11) · solucionario págs. 26–27.

Clase 19.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO

19.7 Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
7 preguntas reales 2013–2025

3.01.1.004 Diabetes y embarazo — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Macrosomía fetal

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Diagnóstico en 1.er trimestre**: Glicemia en ayunas **≥ 100 mg/dL** en dos ocasiones define Diabetes Gestacional precoz.
- Glicemia en ayunas **≥ 126 mg/dL** en 1.er trimestre define Diabetes Pregestacional manifiesta.
- **Tamizaje a las 24-28 semanas**: PTGO con **75 g**; valor a las **2 horas ≥ 140 mg/dL** es diagnóstico.
- **Metas de control**: Glicemia en ayunas < **95 mg/dL** (70-90) y postprandial a las **2 horas** < **120 mg/dL**.
- Si > **20%** de las glicemias exceden la meta tras **1-2 semanas** de dieta, se inicia Insulina.
- La macrosomía fetal se produce por hiperinsulinismo fetal secundario a la hiperglicemia materna.



GRASA SUBCUTÁNEA AUMENTADA
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach, Fig. 6.10

ALGORITMO · DIABETES GESTACIONAL: LOS DOS EXÁMENES Y SUS CORTES

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

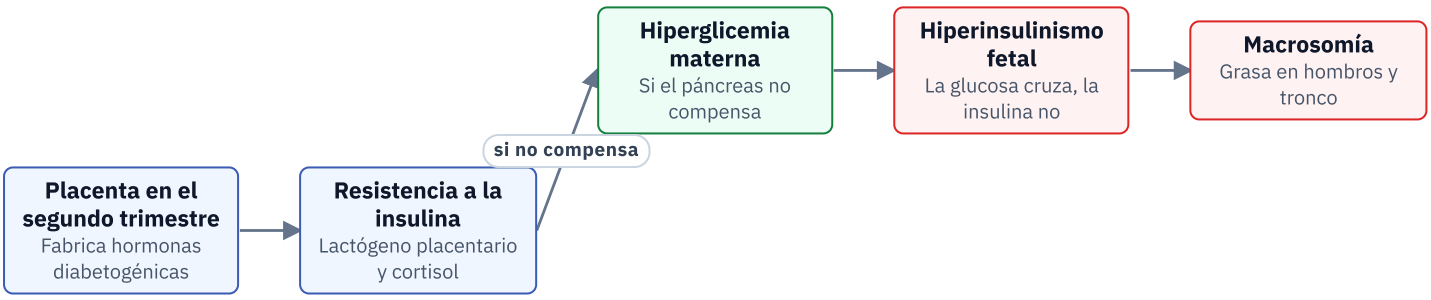


TABLA 19.7 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y METAS GLUCÉMICAS DE LA DIABETES GESTACIONAL (GUÍA PERINATAL MINSAL)

ETAPA / MOMENTO	PRUEBA DE LABORATORIO	VALOR DIAGNÓSTICO	META TERAPÉUTICA CON TRATAMIENTO
Primer Trimestre (< 12 sem)	Glicemia en ayunas (x 2 días)	≥ 100 mg/dL en dos ocasiones	Ayunas: 70 a 90 mg/dL (< 95 mg/dL)
Semana 24 a 28	PTGO 75g (Glicemia a las 2 horas)	≥ 140 mg/dL a las 2 horas	Postprandial 1 hora: < 140 mg/dL
Cualquier momento	Glicemia casual o al azar	≥ 200 mg/dL (DM Pregestacional)	Postprandial 2 horas: < 120 mg/dL
Postparto (6-12 semanas)	PTGO 75g de reclasificación	≥ 140 mg/dL = Intolerancia o DM2	Normal < 140 mg/dL

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	DIAGNÓSTICO	ERROR FRECUENTE
Glicemia de ayuno de 108, confirmada	Diabetes gestacional precoz	Pedir la PTGO de inmediato
PTGO con 2 horas en 152	Diabetes gestacional, sin importar la basal	Decir que es normal porque la basal era baja
28% de controles fuera de meta tras dieta	Iniciar insulina	Mantener solo la dieta y reevaluar en un mes

REGLA DE ORO **Primer trimestre: ayuno** — 100 a 125, confirmar; 126 o más, pregestacional

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **29–33** (págs. 11–12) · solucionario págs. 27–28.

Clase 19.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO

19.8 Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
6 preguntas reales 2013–2025

3.01.1.003 Colestasia gravídica — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- Prurito palmoplantar nocturno sin lesiones cutáneas primarias en el tercer trimestre = CIE.
- El riesgo fetal mayor es la muerte intrauterina súbita por arritmia cardíaca fetal inducida por ácidos biliares.
- El monitoreo fetal (RBNE) no predice el óbito en CIE; la prevención es la interrupción programada.
- El examen de confirmación estándar de oro es la medición de Ácidos Biliares Séricos Totales.
- Ácidos biliares **≥ 40 umol/L** define CIE severa; **≥ 100 umol/L** es de riesgo extremo de óbito.
- El fármaco de elección es el Ácido Ursodesoxicólico (UDCA) a **10-15 mg/kg**/día oral.
- **Momento de interrupción**: 37-38 sem en anictérica moderada (< 40 umol/L); 36 sem en severa (**≥ 40 umol/L**).

ALGORITMO · COLESTASIA INTRAHEPÁTICA: DIAGNÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

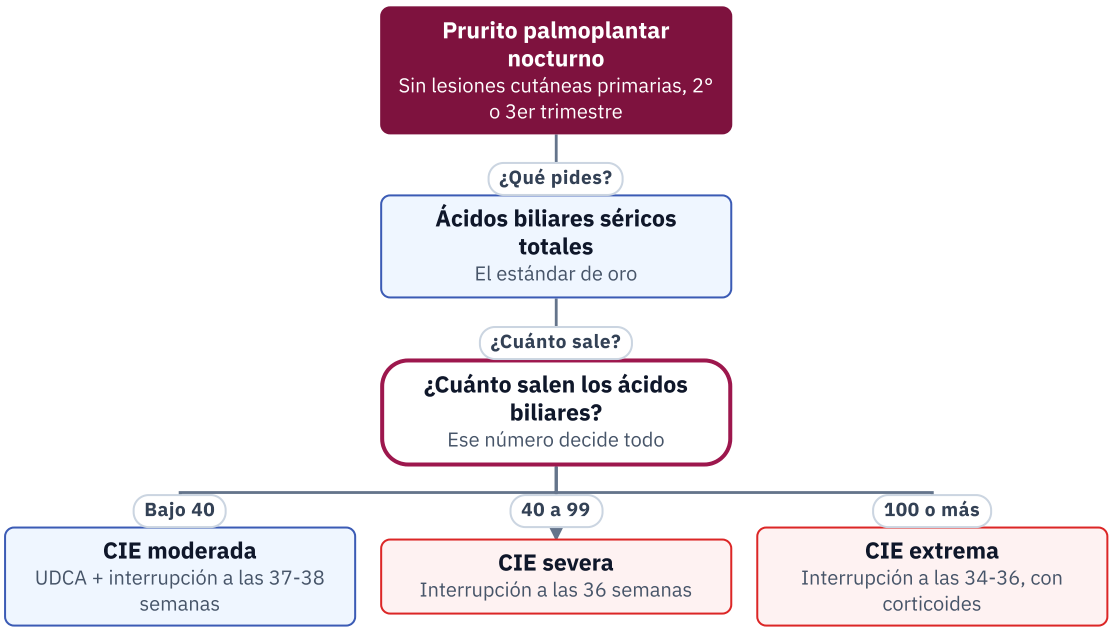


TABLA 19.8 · ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y CRITERIOS DE INTERRUPCIÓN EN COLESTASIA INTRAHEPÁTICA

CATEGORÍA CLÍNICA	NIVEL DE ÁCIDOS BILIARES	PRESENCIA DE ICTERICIA	EDAD GESTACIONAL DE INTERRUPCIÓN
CIE Leve / Moderada	10 a 39 umol/L	Anictérica (Bilirrubina normal)	Semana 37 a 38
CIE Severa	40 a 99 umol/L	Anictérica o Ictérica	Semana 36
CIE Extrema / Alto Riesgo	≥ 100 umol/L	Frecuentemente ictérica	Semana 34 a 36 (con corticoides)

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Prurito palmoplantar sin lesiones primarias	Diagnóstico clínico + ácidos biliares	Buscar una lesión cutánea que lo explique
Ácidos biliares en 110	Interrupción entre 34 y 36 semanas	Solo subir la dosis de ácido ursodesoxicólico
Registro basal no estresante normal	No descarta el riesgo de óbito	Confiar en que el monitoreo protege al feto

REGLA DE ORO **Prurito palmoplantar nocturno** — Sin lesiones primarias, en el tercer trimestre

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **34–36** (pág. 12) · solucionario pág. 28.

Clase 19.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO

19.9 Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda

★★★ PRIORIDAD ALTA
16 preguntas reales 2013–2025

3.01.1.019 Infecciones genitourinarias — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Pielonefritis aguda complicada

LO QUE TE PREGUNTAN

- La bacteriuria asintomática en el embarazo SE TRATA SIEMPRE para prevenir pielonefritis y parto prematuro.
- **Diagnóstico de BA**: Urocultivo por segundo chorro con **≥ 100.000 UFC/mL** sin síntomas.
- **Antibiótico ambulatorio de 1.ª línea para BA y cistitis**: Cefadroxilo oral por **7 días**.
- La Pielonefritis Aguda en el embarazo requiere HOSPITALIZACIÓN INMEDIATA OBLIGATORIA.
- **Tratamiento de pielonefritis**: Cefazolina o Ceftriaxona endovenosa hasta **48h** afebril, completando **14 días** oral.
- **Riesgos de pielonefritis gestacional**: Sepsis grave, SDRA materno y amenaza de parto prematuro.

ALGORITMO · INFECCIÓN URINARIA EN EL EMBARAZO: QUÉ SE TRATA Y DÓNDE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

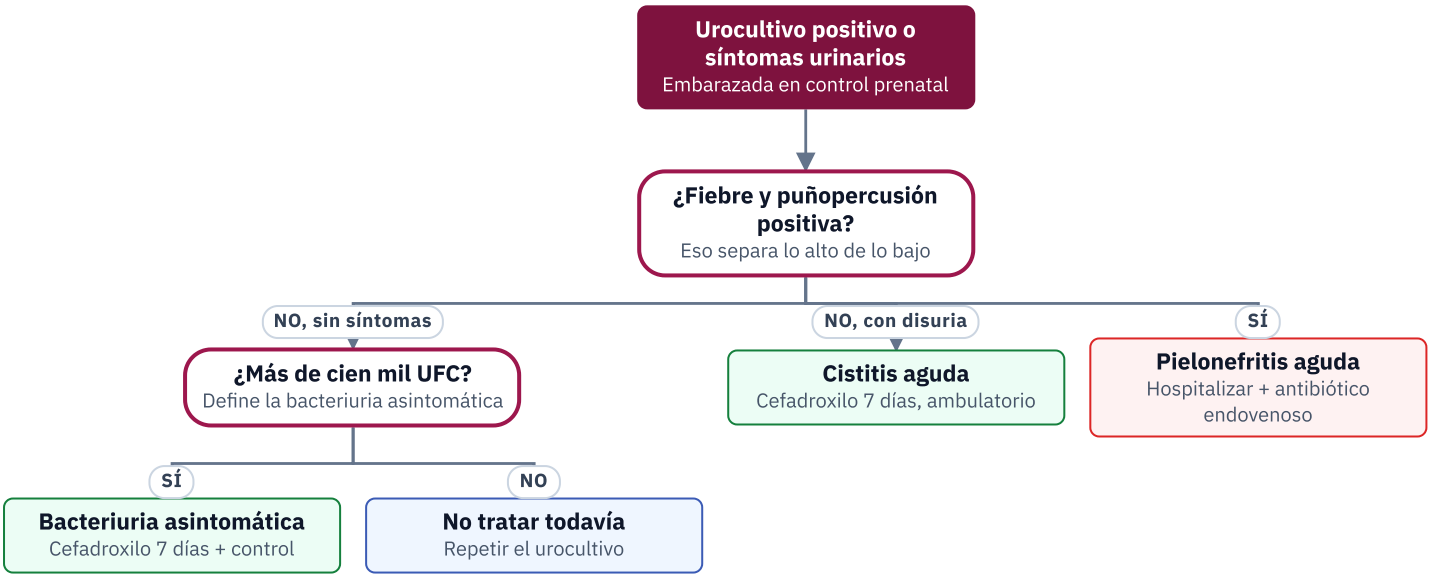


TABLA 19.9 · ESPECTRO CLÍNICO Y MANEJO DE LAS INFECCIONES URINARIAS EN EL EMBARAZO (MINSAL)

CUADRO CLÍNICO	MANIFESTACIONES CARDINALES	LUGAR DE TRATAMIENTO	ESQUEMA ANTIBIÓTICO DE ELECCIÓN
Bacteriuria Asintomática	Sin síntomas · Urocultivo ≥ 10^5 UFC/mL	Ambulatorio	Cefadroxilo 500 mg c/12h x 7 días (o Nitrofurantoína)
Cistitis Aguda	Disuria, polaquiuria, urgencia, afebril	Ambulatorio	Cefadroxilo 500 mg c/12h x 7 días
Pielonefritis Aguda	Fiebre alta, calofríos, dolor lumbar, PPL (+)	Hospitalización OBLIGATORIA	Cefazolina 1g c/8h EV o Ceftriaxona 1-2g c/24h EV x 14d
Profilaxis Secundaria	Post-pielonefritis o ITU recurrente	Ambulatorio continuo	Cefadroxilo 500 mg o Nitrofurantoína 100 mg cada noche

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CUADRO	CLÍNICA	CONDUCTA
Menos de cien mil UFC, sin síntomas	No es bacteriuria asintomática	No tratar, repetir el urocultivo

REGLA DE ORO — **Más de cien mil UFC** — Sin síntomas: se trata siempre en el embarazo

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **53–54** (págs. 15–16) · solucionario pág. 32.

Clase 19.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO

19.21 Cardiopatía, Embarazo Múltiple e Hiperemesis Gravídica: Riesgo Materno, Corionicidad y Manejo Inicial

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
7 preguntas reales 2013–2025

1.01.3.002 Cardiopatía y embarazo — Conocimiento general

También: Embarazo múltiple · Hiperemesis gravídica

LO QUE TE PREGUNTAN

- Hipertensión pulmonar severa o Eisenmenger (mortalidad materna de **30-50%**) contraindica el embarazo; las lesiones reparadas y las insuficiencias leves se toleran bien.
- El gasto cardíaco sube **30-50%** en el embarazo y el período más riesgoso es el postparto inmediato (**24-72 horas**); el parto vaginal es de elección en la cardiópata.
- IECA, ARA-II, amiodarona y estatinas están contraindicados; la estenosis mitral es la valvulopatía que más descompensa.
- **En el gemelar se determina la corionicidad a las 11-14 semanas**: signo lambda es bicorial, signo T es monocorial.
- **Interrupción del gemelar**: bicorial a las **38 semanas**, monocorial biamniótico a las 36 y monoamniótico a las **32-34 semanas** por cesárea.

ALGORITMO · CARDIOPATÍA, GEMELAR E HIPEREMESIS: CONDUCTA INICIAL

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

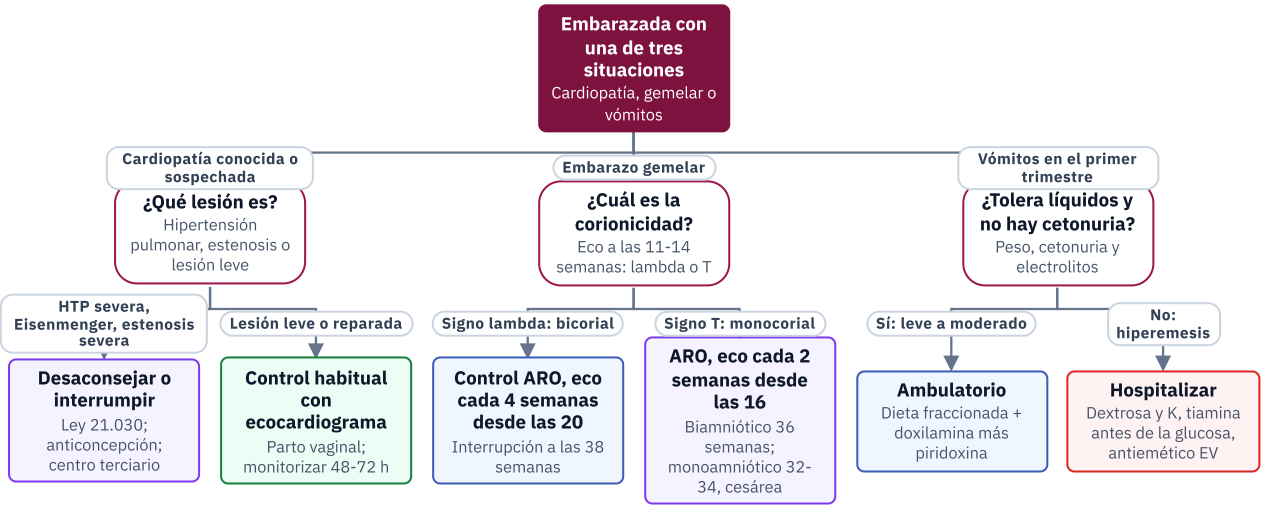


TABLA 19.21 · CARDIOPATÍA, EMBARAZO MÚLTIPLE E HIPEREMESIS: CONDUCTA INICIAL

SITUACIÓN	DATO CLÍNICO CLAVE	CONDUCTA DEL MÉDICO GENERAL	CUÁNDO DERIVAR
Cardiopatía de riesgo muy alto	Hipertensión pulmonar severa o Eisenmenger, estenosis severa sintomática, Marfan con aorta dilatada	Desaconsejar o interrumpir el embarazo (Ley 21.030) y dar anticoncepción segura	Siempre a centro terciario
Cardiopatía bien tolerada	CIA/CIV pequeña, prolapso mitral, insuficiencia leve	Control habitual con ecocardiograma, tratar anemia e HTA	Si aparece disnea o arritmia
Gemelar bicorial	Signo lambda, 2 placentas	Control ARO, interrupción a las 38 semanas si no hay complicaciones	Todo embarazo múltiple
Gemelar monocorial	Signo T, riesgo de transfusión feto-fetal	Eco cada 2 semanas desde las 16; interrupción a las 36 semanas (biamniótico)	Siempre; monoamniótico 32-34 semanas por cesárea
Náuseas y vómitos leves	Tolera líquidos, sin cetonuria	Dieta fraccionada y doxilamina más piridoxina	Si no responde

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

SITUACIÓN	CONDUCTA	DERIVAR
Gemelo muerto en bicorial (2.°-3.er trimestre)	Bienestar fetal y pruebas de coagulación	No interrumpir de inmediato
Vómitos con hipertensión en la 2.ª mitad	Sospechar HELLP	No es hiperemesis

REGLA DE ORO **Eisenmenger o HTP severa: no embarazo** — Mortalidad materna 30-50%

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, pregunta **19** (pág. 10) · solucionario pág. 25.

Clase 19.21 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · METRORRAGIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

19.10 Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030

★★★ PRIORIDAD ALTA
16 preguntas reales 2013–2025

3.01.1.001 Aborto espontáneo — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Aborto provocado · Derechos y aspectos legales de la embarazada y su pareja

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Amenaza de aborto**: Sangrado + dolor pero OCI CERRADO y embrión con LCF POSITIVOS en la eco TV.
- **Aborto en evolución o inevitable**: Metrorragia dolorosa con OCI ABIERTO / PERMEABLE.
- **Aborto incompleto**: OCI abierto con restos ovulares heterogéneos y endometrio engrosado (> **15 mm**).
- **Aborto completo**: OCI cerrado, útero involucionado y cavidad endometrial vacía lineal (< **8-10 mm**).
- **Criterio ecográfico de aborto retenido**: Embrión con LCN **≥ 7 mm** SIN LCF, o saco **≥ 25 mm** sin embrión.



SACO SIN EMBRIÓN
Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 124

ALGORITMO · METRORRAGIA DEL PRIMER TRIMESTRE: QUÉ FORMA DE ABORTO ES



TABLA 19.10 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO Y ECOGRÁFICO DE LAS FORMAS DE ABORTO

FORMA CLÍNICA	METRORRAGIA	DOLOR CÓLICO	ORIFICIO CERVICAL INTERNO (OCI)	ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Amenaza de Aborto	Escasa a moderada	Leve o nulo	CERRADO	Saco normoinserto con embrión y LCF (+)	Reposo relativo, descartar ITU/vaginitis, analgesia SOS
Aborto en Evolución	Moderada a abundante	Intenso y rítmico	ABIERTO / PERMEABLE	Restos o saco en cérvix, desprendimiento	Hospitalización, analgesia, preparar evacuación
Aborto Incompleto	Abundante con coágulos	Moderado a severo	ABIERTO / PERMEABLE	Restos ovulares heterogéneos, endometrio > 15 mm	Evacuación uterina: AMEU o Misoprostol 800 mcg
Aborto Completo	Mínima o cesó	Cede progresivamente	CERRADO	Cavidad vacía, endometrio fino regular < 8-10 mm	Observación ambulatoria, control clínico
Aborto Retenido	Nula o escasa mancha	Ausente	CERRADO	LCN ≥ 7mm sin LCF o DMSG ≥ 25mm sin embrión	Misoprostol 800 mcg vaginal o AMEU electivo
Aborto Séptico	Purulenta / Fétida	Severo continuo	Generalmente ABIERTO	Restos uterinos + hiperemia / colecciones	Hospitalización UCI, ATB triple EV + AMEU/LUI en 2-4h

REGLA DE ORO **Primero, mira el cuello** — Cerrado o abierto

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **38–44** (págs. 13–14) · solucionario págs. 29–30.

Clase 19.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · METRORRAGIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

19.11 Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico

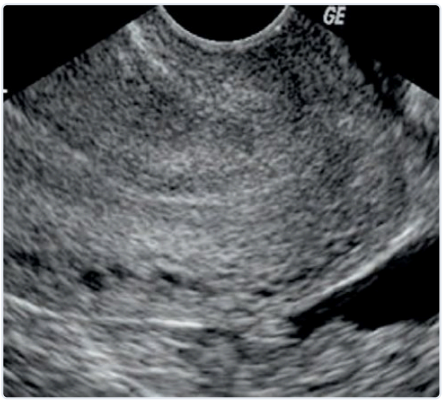
★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

3.01.1.006 Embarazo ectópico no complicado — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Embarazo ectópico complicado · HCG cuantitativa

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Localización más frecuente del embarazo ectópico**: Trompa de Falopio, región ampular (**75-80%**).
- **Localización tubárica más peligrosa por hemorragia masiva**: Porción intersticial o cornual.
- **Factor de riesgo mayor más potente**: Antecedente personal de embarazo ectópico previo.
- **Zona discriminatoria ecográfica de β-hCG**: **1.500 a 2.000 UI**/L. Si el útero está vacío, es ectópico.
- **Criterios indispensables para Metotrexato**: Paciente estable, β-hCG < **5.000 UI**/L, masa < **3.5 cm** y LCF (-).



LÍQUIDO LIBRE EN DOUGLAS
Diagnostic Ultrasound (Rumack), p. 1121

ALGORITMO · EMBARAZO ECTÓPICO: ROTO, FÁRMACO, O CIRUGÍA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

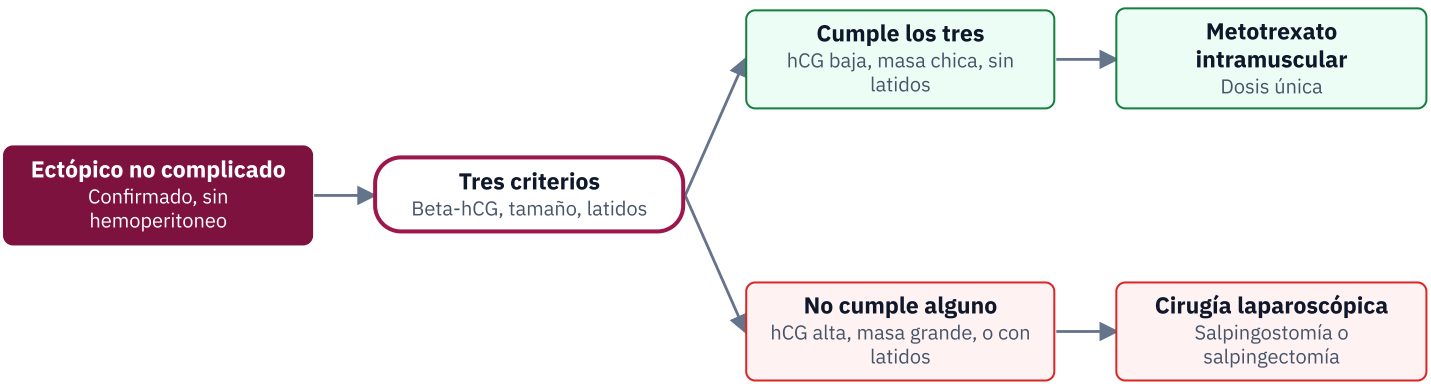


TABLA 19.11 · CRITERIOS DE ELECCIÓN TERAPÉUTICA EN EMBARAZO ECTÓPICO (MINSAL / ACOG)

MODALIDAD	INDICACIONES Y CRITERIOS	CONTRAINDICACIONES	PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO
Manejo Expectante	β-hCG < 1.000 UI/L en franco descenso espontáneo, asintomática, masa < 2 cm	Dolor, β-hCG en ascenso, inestabilidad	β-hCG bisemanal hasta negativización total
Tratamiento Médico (Metotrexato)	Estable hemodinámicamente, β-hCG < 5.000 UI/L, masa < 3.5 cm, SIN actividad cardíaca	Inestabilidad, hemoperitoneo, LCF (+), falla renal/hepática, trombocitopenia	β-hCG en Día 4 y 7 (descenso ≥ 15%), luego semanal hasta < 5 UI/L
Salpingostomía Laparoscópica	Deseo de fertilidad futura, trompa contralateral ausente o enferma, trompa no rota	Trompa severamente destruida, hemorragia incoercible, paridad satisfecha	β-hCG semanal hasta negativizar (riesgo de tejido trofoblástico retenido)
Salpingectomía Laparoscópica	Trompa rota, hemoperitoneo importante, paridad cumplida, ectópico recurrente	Negativa de la paciente ante trompa única	Control postoperatorio estándar, Rhogam si Rh (-)

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Inestable, con dolor peritoneal	Cirugía de urgencia	Pedir ecografía o esperar la beta-hCG
Beta-hCG mayor a la zona discriminatoria, útero vacío	Ectópico confirmado	Pedir otra ecografía en una semana
Cumple los tres criterios de metotrexato	Tratamiento médico	Operar de entrada por costumbre

REGLA DE ORO **Inestable: cirugía ya** — Ningún examen se interpone

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **45–50** (págs. 14–15) · solucionario págs. 30–31.

Clase 19.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · METRORRAGIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

19.12 Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
7 preguntas reales 2013–2025

3.01.1.008 Enfermedad del trofoblasto — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: HCG cuantitativa

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Mola completa**: 46XX diploide **100%** paterno, sin embrión, imagen en tormenta de nieve, β-hCG > 100.000.
- **Mola parcial**: 69XXY triploide, con presencia de tejido embrionario malformado y vellosidades focales.
- Preeclampsia antes de la semana 20 de gestación es casi sinónimo de Mola Hidatiforme en el EUNACOM.
- **Quistes tecaluteínicos ováricos bilaterales**: Causados por el hiperestímulo masivo de la β-hCG sobre receptores de LH.
- **Tratamiento primario de elección**: Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o aspiración al vacío.

ALGORITMO · ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL: DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

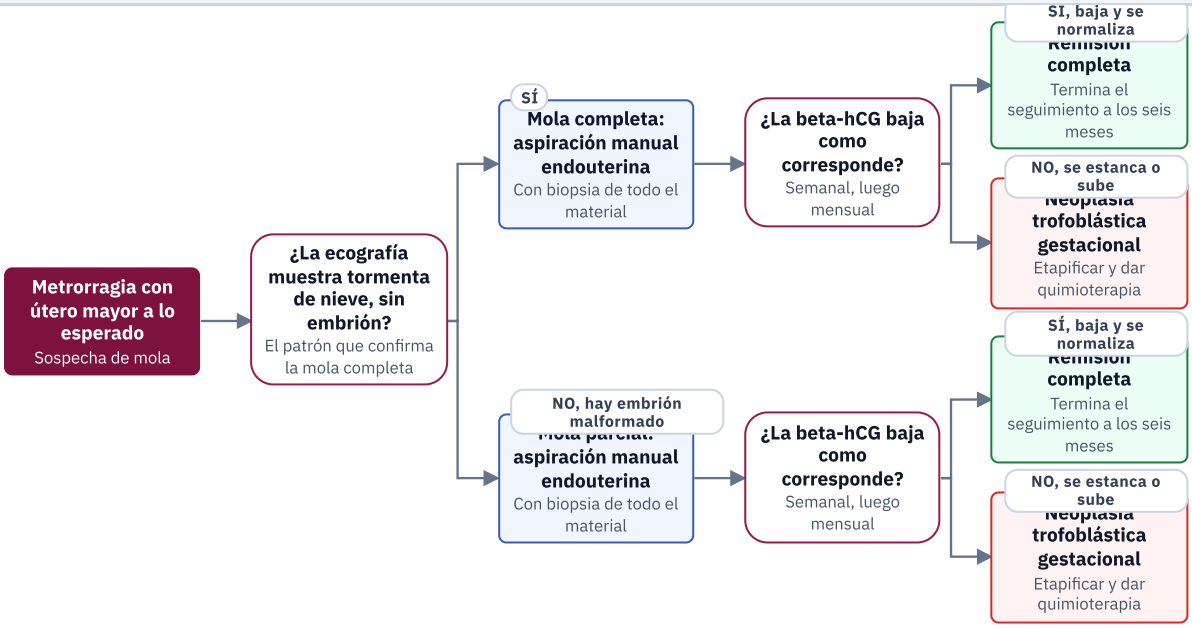


TABLA 19.12 · DIFERENCIAS CLAVE ENTRE MOLA HIDATIFORME COMPLETA Y MOLA HIDATIFORME PARCIAL

CARACTERÍSTICA	MOLA HIDATIFORME COMPLETA	MOLA HIDATIFORME PARCIAL
Cariotipo	46,XX (90%) o 46,XY (10%) · Diploide 100% paterno	69,XXY (70%), 69,XXX o 69,XYY · Triploide (materno + 2 paternos)
Tejido Fetal / Embrión	AUSENTE (nunca hay embrión ni eritrocitos fetales)	PRESENTE (embrión no viable con malformaciones múltiples)
Vellosidades Coriónicas	Edema hidrópico difuso y generalizado ('racimo de uvas')	Edema hidrópico focal intercalado con vellosidades normales
Niveles de β-hCG	Masivamente elevados (habitualmente > 100.000 UI/L)	Normales o discretamente elevados (< 50.000 UI/L)
Tamaño Uterino	Mayor a la edad gestacional en 50% de los casos	Menor o igual a la edad gestacional estimada
Complicaciones Clínicas	Preeclampsia < 20 sem, quistes tecaluteínicos, tirotoxicosis	Raras; clínica indistinguible de aborto incompleto común
Ecografía Transvaginal	Patrón característico en 'tormenta de nieve' o 'panal'	Saco deformado con tejido trofoblástico focal + partes fetales

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CARACTERÍSTICA	MOLA COMPLETA	MOLA PARCIAL
Beta-hCG	Muy elevada, sobre cien mil	Normal o algo elevada
Riesgo de neoplasia	Quince a veinte por ciento	Uno a cinco por ciento

REGLA DE ORO **Tormenta de nieve, sin embrión** — Beta-hCG muy elevada

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **51–52** (pág. 15) · solucionario págs. 31–32.

Clase 19.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · METRORRAGIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

19.13 Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa

★★★ PRIORIDAD ALTA
18 preguntas reales 2013–2025

Máxima rentabilidad · Diagnóstico diferencial estricto entre sangrado indoloro (Placenta Previa) vs sangrado doloroso con hipertonía (DPPNI)

3.01.2.011 **Metrorragia: placenta previa** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Metrorragia: Desprendimiento previo de placenta normoinserta (DPPNI) · Rotura uterina · Cesárea

LO QUE TE PREGUNTAN

- **REGLA DE ORO**: ¡PROHIBIDO EL TACTO VAGINAL en hemorragias del 3° trimestre sin conocer la posición placentaria!
- **Placenta Previa**: Metrorragia roja rutilante, fresca, indolora, útero blando y relajado, FCF normal.
- **DPPNI**: Metrorragia oscura con coágulos, dolor lacerante intenso, hipertonía uterina en tabla y sufrimiento fetal precoz.
- **Factor de riesgo principal de DPPNI**: Hipertensión materna (Preeclampsia / HTA crónica).
- **Factor de riesgo principal de Placenta Previa**: Cicatriz de cesárea anterior y legrados uterinos.
- La ecografía normal NO descarta DPPNI, ya que el diagnóstico del desprendimiento es eminentemente CLÍNICO.
- **Rotura Uterina**: Dolor desgarrador brusco, cese repentino de contracciones y ascenso de la presentación fetal.



ECO TRANSVAGINAL
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach, p. 157

ALGORITMO · METRORRAGIA DE LA SEGUNDA MITAD: QUÉ ACOMPAÑA AL SANGRADO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

Metrorragia después de 20 semanas
Nunca tacto vaginal a ciegas

- Indolora, útero blando → **Placenta previa**: Eco TV + cesárea electiva a las 37 semanas
- Dolor + útero leñoso → **DPPNI**: Cesárea de urgencia inmediata
- Cesárea previa + cese de contracciones → **Rotura uterina**: Laparotomía de urgencia
- Sangra justo al romper membranas → **Rotura de vasa previa**: Cesárea en minutos

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **55–60** (págs. 16–17) · solucionario págs. 32–33.

Clase 19.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · METRORRAGIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

19.13 Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa

★★★ PRIORIDAD ALTA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 19.13 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO DE LAS METRORRAGIAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

CARACTERÍSTICA	PLACENTA PREVIA	DESPRENDIMIENTO (DPPNI)	ROTURA UTERINA	ROTURA DE VASA PREVIA
Comienzo	Insidioso, progresivo	Súbito, brusco	Súbito durante el trabajo de parto	Inmediato tras la amniorrexis
Tipo de Sangrado	Rojo rutilante, fresco, sin coágulos	Rojo oscuro, negruzco, con coágulos (u oculto)	Variable, rojo oscuro a rutilante	Escaso a moderado (sangre 100% fetal)
Dolor Abdominal	Ausente (totalmente indoloro)	Intenso, lacerante, continuo	Dolor desgarrador que cede tras rotura	Ausente (indoloro)
Tono Uterino	Blando, relajado, normal	Hipertónico ('útero leñoso' o en tabla)	Atonía súbita (cesan las contracciones)	Normal, sin hipertonía
Estado Fetal	Normal (bienestar conservado)	Sufrimiento fetal precoz / DIP II / Muerte	Bradicardia fetal extrema / Desaparición LCF	Bradicardia fetal extrema catastrófica
Estado Materno	Compromiso proporcional al sangrado externo	Shock desproporcionado al sangrado visible	Shock hipovolémico peritoneal rápido	Madre totalmente estable y asintomática
Asociación Típica	Cesárea anterior, multípara	Preeclampsia, traumatismo, cocaína	Cicatriz uterina, uso de oxitócicos	Inserción velamentosa del cordón
Conducta	Eco TV (¡No tacto!), cesárea electiva 37s	Cesárea de urgencia inmediata	Laparotomía inmediata de salvataje	Cesárea emergente inmediata

TRAMPAS EUNACOM

CUADRO	DOLOR Y TONO	BANDERA CLAVE	CONDUCTA
Placenta previa	Indolora, útero blando	Sangre roja fresca	Eco TV, cesárea a las 37 semanas
DPPNI	Dolor intenso, útero leñoso	La eco normal no descarta	Cesárea de urgencia
Rotura uterina	Cesa el dolor y las contracciones	La presentación asciende	Laparotomía inmediata

REGLA DE ORO **Nunca tacto vaginal a ciegas** — Primero localiza la placenta con ecografía

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

Las hemorragias de la segunda mitad del embarazo (> 20 semanas) constituyen emergencias de alto riesgo perinatal que demandan un diagnóstico diferencial inmediato. La regla de oro mandatoria y pregunta fija de examen es: ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO REALIZAR UN TACTO VAGINAL a ciegas en una embarazada que sangra en el tercer trimestre, debido a que si se trata de una Placenta Previa, el dedo puede perforar la placenta y desatar una hemorragia exanguinante fulminante. El diagnóstico diferencial se fundamenta en la semiología del dolor y el tono uterino: Placenta Previa (sangrado rojo brillante, rutilante, indoloro, útero blando y relajado) versus DPPNI (metrorragia oscura, dolor abdominal intenso, hipertonía uterina en tabla y sufrimiento fetal precoz).

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **55–60** (págs. 16–17) · solucionario págs. 32–33.

Clase 19.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PARTO PREMATURO, MECANISMO DEL PARTO, PUERPERIO & URGENCIAS OBSTÉTRICAS

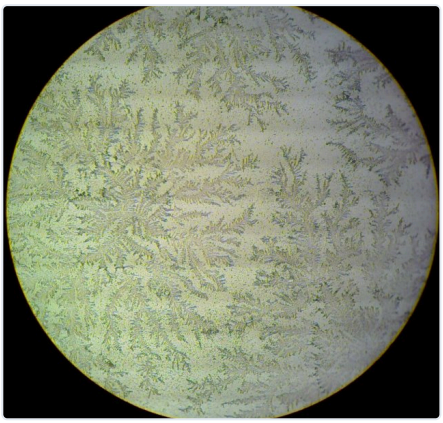
19.14 Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
12 preguntas reales 2013–2025

3.01.2.014 Rotura prematura de membranas — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Diagnóstico de RPM**: Especuloscopía estéril con maniobra de Valsalva o Tarnier.
- ¡PROHIBIDO EL TACTO VAGINAL DIGITAL en sospecha de RPM sin trabajo de parto activo!
- **Test confirmatorios en duda**: Cristalografía en hoja de helecho, Nitrazina (pH > 6.5) y PAMG-1 (AmniSure).
- **Manejo en ≥ 34 semanas**: Interrupción del embarazo (inducción) + profilaxis SGB si indicada.
- **Manejo en 24 a 33+6 semanas**: Hospitalización en ARO, antibióticos de latencia x **7 días** y corticoides (Betametasona).
- **Neuroprotección con Sulfato de Magnesio**: Obligatoria si el parto es inminente en gestaciones < **32 semanas**.



TEST DE HELECHO
Wikimedia Commons «Positive Fern Test.jpg», CC BY-SA 2.0, ver autor en Commons

ALGORITMO · ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS: EDAD GESTACIONAL E INFECCIÓN

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción



TABLA 19.14 · MANEJO ESCALONADO DE LA ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS SEGÚN EDAD GESTACIONAL (MINSAL)

EDAD GESTACIONAL	OBJETIVO PRIMARIO	CORTICOIDES	ANTIBIOTICOTERAPIA	MOMENTO DE INTERRUPCIÓN
< 24 semanas (Previable)	Consejería familiar, riesgo de hipoplasia pulmonar y deformidades	No indicados	Discutir opciones; antibióticos si manejo expectante	Según decisión informada de los padres y estado infeccioso
24 a 31+6 semanas	Prolongar latencia y proteger órganos fetales (SNC y pulmón)	Betametasona 12 mg IM c/24h x 2 dosis + Sulfato Mg	Ampicilina + Eritromicina EV x 48h, luego Amoxi + Eritro oral hasta 7d	Interrumpir a las 34 sem (o antes si hay corioamnionitis)
32 a 33+6 semanas	Prolongar latencia y maduración pulmonar	Betametasona 12 mg IM c/24h x 2 dosis	Ampicilina + Eritromicina (esquema de latencia 7 días)	Interrumpir a las 34 semanas cumplidas
≥ 34 semanas	Evitar morbilidad infecciosa materno-fetal	No indicados	Profilaxis SGB intraparto (Penicilina o Ampicilina EV) si > 12-18h	INTERRUPCIÓN INMEDIATA (inducción del parto)
Cualquier EG con Corioamnionitis	Salvar la vida materna y tratar sepsis neonatal	CONTRAINDICADOS	Ampicilina 2g c/6h EV + Gentamicina 5 mg/kg EV (+ Clinda si cesárea)	INTERRUPCIÓN INMEDIATA EXPEDITA (sin demora)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA	ERROR FRECUENTE
RPM entre 24 y 33 más 6	Antibióticos, corticoides, vigilancia	Interrumpir sin necesidad
Sospecha de RPM sin claridad	Especuloscopía y PAMG-1	Tacto vaginal digital
Corioamnionitis clínica	Interrumpir ya, antibióticos EV	Dar corticoides o tocolíticos

REGLA DE ORO **Especuloscopía, nunca tacto digital** — Confirmas con PAMG-1 si hay duda

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **61–67** (págs. 17–18) · solucionario págs. 34–35.

Clase 19.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PARTO PREMATURO, MECANISMO DEL PARTO, PUERPERIO & URGENCIAS OBSTÉTRICAS

★★★
PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

19.15 Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección

3.01.2.012 Parto prematuro — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Definición de APP**: Dinámica uterina frecuente (**≥ 4 en 20 min**) + modificaciones cervicales entre 22 y **34 semanas**.
- **Cervicometría transvaginal**: Corte de < **25 mm** define cérvix corto y alto riesgo de parto prematuro.
- Prevención GES con Progesterona micronizada vaginal (**200 mg**/noche) ante cérvix < **25 mm** o APP previa.
- **Tocolítico de primera línea**: Nifedipino oral por un máximo de **48 horas** (su único fin es permitir el efecto corticoide).
- **Maduración pulmonar**: Betametasona **12 mg** IM c/**24h** x 2 dosis entre 24 y **34 semanas**.
- **Neuroprotección con Sulfato de Magnesio**: Obligatoria ante parto inminente en gestaciones < **32 semanas**.



CERVICOMETRÍA
Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 159

ALGORITMO · AMENAZA DE PARTO PREMATURO: LOS CUATRO PILARES DEL MANEJO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

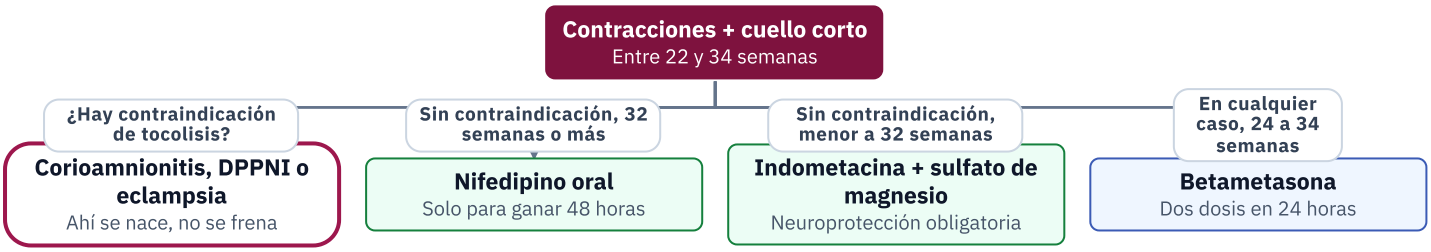


TABLA 19.15 · INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS FUNDAMENTALES EN AMENAZA DE PARTO PREMATURO (MINSAL)

INTERVENCIÓN	FÁRMACO Y DOSIS	POBLACIÓN DIANA	BENEFICIO CLÍNICO PRINCIPAL
Tocolisis Aguda	Nifedipino oral: 20 mg inicial, luego 10-20 mg c/6-8h x 48h máx	24 a 34 semanas con dinámica activa y cérvix modificado	Frena dinámica 48h para permitir acción de corticoides y traslado
Maduración Pulmonar	Betametasona 12 mg IM c/24h x 2 dosis (o Dexa 6 mg c/12h x 4 dosis)	24 a 34 semanas con riesgo de parto pretérmino	Reduce enf. de membrana hialina, hemorragia intraventricular y muerte
Neuroprotección Fetal	Sulfato de Magnesio: bolo 4-5 g EV en 30 min + infusión 1 g/h	Menores de 32 semanas con parto inminente en < 24h	Reduce significativamente parálisis cerebral y disfunción motora
Profilaxis SGB	Penicilina G 5 mill UI EV inicial + 2.5 mill c/4h (o Ampicilina)	Todo parto prematuro (< 37 sem) con SGB (+) o desconocido	Previene sepsis neonatal precoz, meningitis y neumonía por SGB
Prevención Primaria	Progesterona micronizada vaginal 200 mg/noche hasta 36 sem	Asintomáticas con cuello < 25 mm a las 20-24 sem o APP previa	Reduce parto prematuro espontáneo en un 40 a 50% (GES)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

SITUACIÓN	CONDUCTA	ERROR FRECUENTE
Cuello corto, sin antecedentes	Progesterona vaginal	Hacer un cerclaje de rutina
APP desde las 32 semanas	Nifedipino oral	Usar indometacina
Corioamnionitis o DPPNI	Nunca tocolisis, se interrumpe	Intentar frenar el parto

REGLA DE ORO **Cuello menor a 25 milímetros** — El predictor más fuerte de parto prematuro

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **68–70** (pág. 18) · solucionario pág. 35.

Clase 19.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PARTO PREMATURO, MECANISMO DEL PARTO, PUERPERIO & URGENCIAS OBSTÉTRICAS

PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

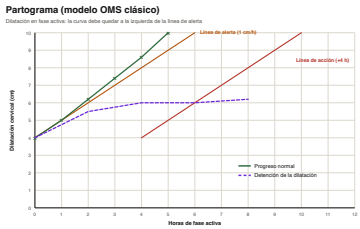
19.16 Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento

Alta rentabilidad · Fases del parto (fase activa desde 5 cm), componentes del Score de Bishop y regla de oro del Manejo Activo del Alumbramiento

3.01.5.010 **Parto normal** — Realizar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Fase activa del trabajo de parto**: Comienza a partir de los **5 cm** de dilatación cervical según criterios actuales.
- **Score de Bishop > 6 puntos**: Cuello favorable / maduro -> Se induce directamente con Oxitocina EV.
- **Score de Bishop ≤ 6 puntos**: Cuello desfavorable / inmaduro -> Requiere maduración previa con Misoprostol o Balón de Foley.
- El inicio de oxitocina con cuello inmaduro (Bishop bajo) se asocia a alto fracaso de inducción y cesárea innecesaria.
- **Mecanismos del parto en cefálica**: Acomodación y flexión -> Descenso -> Rotación interna -> Desprendimiento -> Rotación externa.
- **Rotación interna de la cabeza**: La variedad de posición final habitual para desprenderse es la Occípito-Púbica.
- **Manejo Activo del Alumbramiento**: 1) Oxitocina **10 UI** IM tras hombro anterior; 2) Tracción controlada; 3) Masaje.



PARTOGRAMA
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · INDUCCIÓN DEL PARTO: LO QUE DECIDE EL CUELLO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 19.16 · SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE MADUREZ CERVICAL: SCORE DE BISHOP

PARÁMETRO CERVICAL	0 PUNTOS	1 PUNTO	2 PUNTOS	3 PUNTOS
Dilatación Cervical	Cerrado	1 a 2 cm	3 a 4 cm	≥ 5 cm
Borramiento Cervical	0 a 30%	40 a 50%	60 a 70%	≥ 80%
Altura de Presentación (Lee)	-3 cm (móvil)	-2 cm (insinuado)	-1 a 0 cm (fijo/encajado)	+1 a +2 cm
Consistencia del Cuello	Firme / Duro	Media	Blanda	-
Posición del Cuello	Posterior	Intermedia	Anterior	-

REGLA DE ORO **Fase activa desde 5 centímetros** — Un centímetro por hora, como mínimo

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **71–72** (pág. 18) · solucionario pág. 36.

Clase 19.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PARTO PREMATURO, MECANISMO DEL PARTO, PUERPERIO & URGENCIAS OBSTÉTRICAS

19.17 Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

★★★ PRIORIDAD ALTA
26 preguntas reales 2013–2025

3.01.2.021 Trabajo parto distócico — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

También: Evaluación intraparto · Sufrimiento fetal agudo · Monitorizacion fetal (estresante y no estresante) · Presentaciones fetales anómalas · Prueba de trabajo de parto

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Distocia de hombros**: Emergencia intraparto anunciada por el 'signo de la tortuga'.
- ¡TERMINANTEMENTE PROHIBIDA la maniobra de Kristeller (presión en fondo uterino) en distocia de hombros!
- ¡Prohibida la tracción violenta o balanceo de la cabeza por riesgo de parálisis de plexo braquial (Erb-Duchenne)!
- **Maniobras de primera línea de elección**: 1) Maniobra de McRoberts + 2) Presión suprapúbica (Mazzanti).
- **DIP I (Desaceleraciones tempranas en espejo)**: Por compresión fisiológica cefálica. Fisiológicas y benignas.
- **DIP II (Desaceleraciones tardías)**: Por hipoxia e insuficiencia útero-placentaria. Sugieren acidosis fetal.



SIGNO DE LA TORTUGA
The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 292

ALGORITMO · URGENCIAS DEL EXPULSIVO: HOMBRO Y MONITOREO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

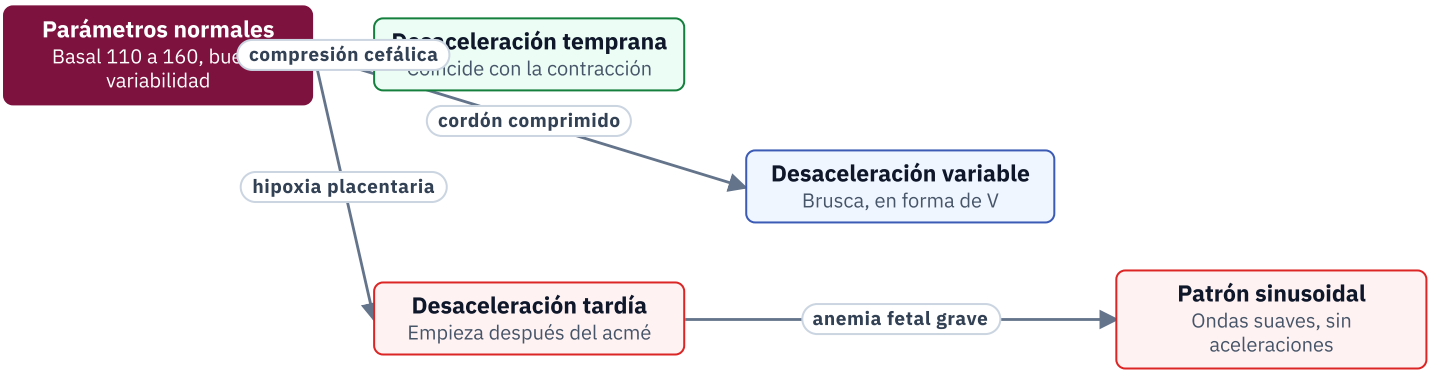


TABLA 19.17 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS DESACELERACIONES CARDÍACAS FETALES INTRAPARTO (FIGO)

TIPO DE DESACELERACIÓN	MORFOLOGÍA Y RELACIÓN CON LA CONTRACCIÓN	FISIOPATOLOGÍA SUBYACENTE	SIGNIFICADO CLÍNICO Y MANEJO
DIP I (Precoces / Tempranas)	Simétricas, coinciden punto a punto con la contracción ('en espejo')	Compresión fisiológica de la cabeza fetal -> Reflejo vagal	TOTALMENTE BENIGNAS. No indican hipoxia. Parto fisiológico.
DIP II (Tardías)	Asimétricas, desfase > 20s respecto al acmé; recuperación tardía	Hipoxia fetal por hipoperfusión útero-placentaria	PATOLÓGICAS (Acidemia fetal). Reanimación intrauterina o CESÁREA.
DIP III (Variables)	Bruscas en 'V', variables en tiempo, amplitud y relación temporal	Compresión transitoria del cordón umbilical (barorreceptores)	Habituales; si son severas (> 60s, < 70 lpm) descartar prolapso de cordón.
Patrón Sinusoidal	Ondas sinusoidales regulares de 2-5 ciclos/minuto sin variabilidad	Compromiso hemodinámico severo por Anemia Fetal Grave	GRAVE EMERGENCIA. Isoinmunización o desgarro de vasa previa -> Cesárea.

TRAMPAS EUNACOM

SITUACIÓN	SE HACE	ERROR FRECUENTE
Hombro atascado, signo de la tortuga	McRoberts más presión suprapúbica	Presionar el fondo uterino
Desaceleración en espejo con la contracción	Observar, es benigna	Tratarla como sufrimiento fetal
Tardías recurrentes sin variabilidad	Reanimación intrauterina y cesárea	Aumentar la oxitocina

REGLA DE ORO **Primero McRoberts** — Más presión suprapúbica de Mazzanti

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **37, 73–79** (págs. 13, 19) · solucionario págs. 29, 36–37.

Clase 19.17 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PARTO PREMATURO, MECANISMO DEL PARTO, PUERPERIO & URGENCIAS OBSTÉTRICAS

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
9 preguntas reales 2013–2025

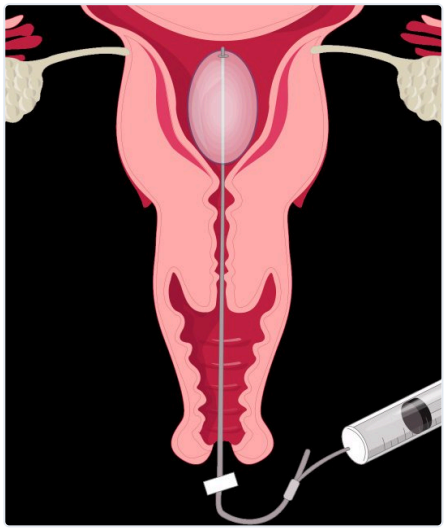
19.18 Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado

Máxima rentabilidad · Regla de las 4T (Tono 70%), Masaje bimanual, Fármacos uterotónicos escalonados, Ácido Tranexámico y Balón de Bakri

3.01.2.008 **Hemorragia genital aguda (metrorragia disfuncional-cervicorragia por Cáncer C.U.)** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Definición de HPI**: Pérdida **≥ 1.000 mL** o sangrado con signos de inestabilidad en las primeras **24 horas**.
- **Causa más frecuente de HPI**: Atonía Uterina (**70%** de los casos).
- **Manejo inicial de la atonía**: Masaje uterino bimanual + Oxitocina EV + Ácido Tranexámico **1g** EV en < **3 horas**.
- ¡METILERGONOVINA CONTRAINDICADA EN HIPERTENSAS / PREECLAMPSIA! Causa crisis hipertensiva y ACV.
- ¡CARBOPROST CONTRAINDICADO EN PACIENTES ASMÁTICAS! Causa broncoespasmo severo letal.
- **Misoprostol 800 mcg rectal/sublingual**: Uterotónico seguro y de elección en pacientes con hipertensión.
- **Taponamiento con Balón de Bakri (300-500 mL)**: Procedimiento mecánico de rescate de elección antes de cirugía.



BALÓN DE BAKRI
Wikimedia Commons «Bakri Balloon Hariadhi.svg», CC BY-SA 4.0, Hariadhi

ALGORITMO · HEMORRAGIA POSTPARTO: LAS CUATRO T

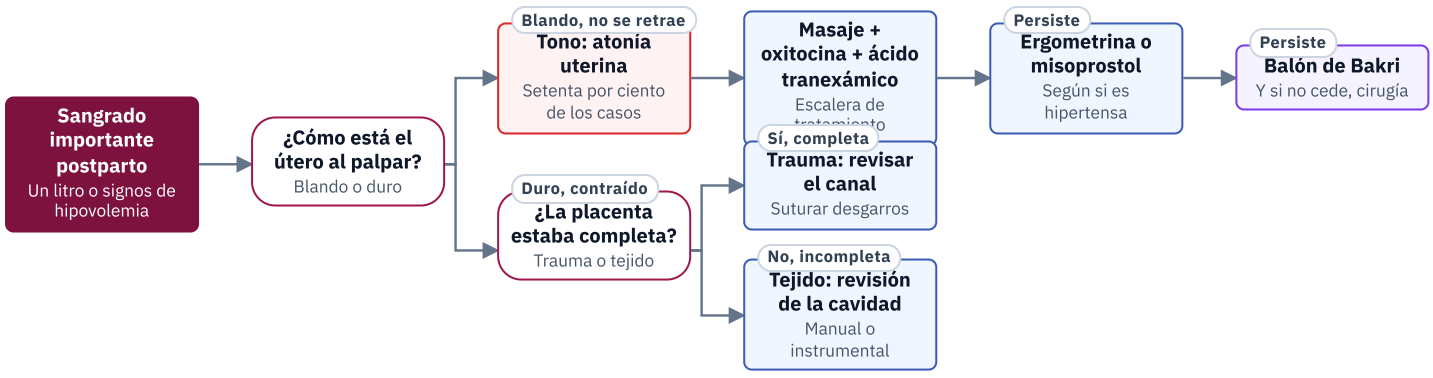


TABLA 19.18 · DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO SEGÚN LA REGLA DE LAS 4T

CAUSA (LAS 4T)	FRECUENCIA	HALLAZGOS CLÍNICOS CARDINALES	TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE ELECCIÓN
Tono (Atonía Uterina)	70%	Útero blando, supraumbilical, no se retrae tras alumbramiento	Masaje bimanual + Oxitocina + Metilergonovina/Misoprostol + TXA + Bakri
Trauma (Laceraciones / Desgarros)	20%	Útero duro y contraído pero sangrado continuo rojo fresco en chorro	Inspección sistemática con valvas y sutura de desgarros de cuello y vagina
Tejido (Restos Placentarios)	10%	Placenta expulsada incompleta con falta de cotiledones o membranas	Revisión manual/instrumental de la cavidad uterina bajo anestesia
Trombina (Coagulopatía)	1%	Sangre no coagula, sangrado difuso 'en napa' por venopunciones	Corrección con hemoderivados (Plasma, Crioprecipitados, Plaquetas)

REGLA DE ORO **Tono: útero blando** — La causa más frecuente, de lejos

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **80–84** (pág. 20) · solucionario págs. 38–39.

Clase 19.18 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PARTO PREMATURO, MECANISMO DEL PARTO, PUERPERIO & URGENCIAS OBSTÉTRICAS

PRIORIDAD MEDIA
11 preguntas reales 2013–2025

19.19 Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)

3.01.2.006 **Endometritis puerperal** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Mastitis puerperal · Mastitis abscedada

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Endometritis puerperal**: Principal causa de morbilidad febril puerperal (debuta al 2°-4° día).
- **Factor de riesgo mayor de endometritis**: Parto por Cesárea (especialmente de urgencia).
- **Clínica de endometritis**: Fiebre + dolor hipogástrico + útero subinvolucionado + loquios fétidos.
- **Antibioticoterapia de elección en endometritis**: Clindamicina **900 mg** c/**8h** EV + Gentamicina **5 mg/kg**/día EV.
- **Duración**: Mantener antibióticos EV hasta **48 horas** afebril. NO requiere mantención oral al alta.

ALGORITMO · FIEBRE PUERPERAL: ÚTERO O MAMA

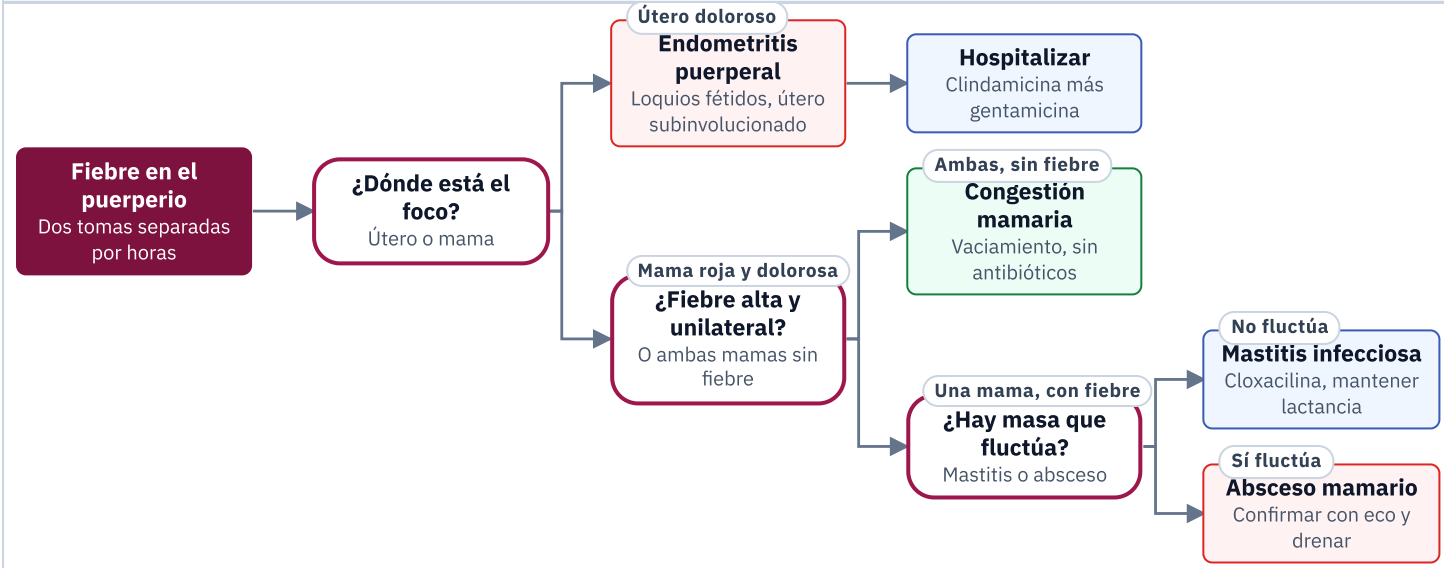


TABLA 19.19 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS CUADROS INFLAMATORIOS MAMARIOS EN EL PUERPERIO

CARACTERÍSTICA	CONGESTIÓN MAMARIA	MASTITIS INFECCIOSA	ABSCESO MAMARIO
Momento de Aparición	2° a 4° día postparto ('bajada de leche')	2.ª a 4.ª semana postparto	Complicación a los 3-7 días de mastitis mal tratada
Afectación	Bilateral, difusa en ambas mamas	Unilateral, sectorial en cuña (típico superoexterno)	Unilateral, masa delimitada fluctuante
Fiebre y Compromiso	Afebril o febrícula leve transitoria (< 24h)	Fiebre alta (38.5-40°C), calofríos intensos	Fiebre remitente o persistente
Etiología	Retención láctea y congestión venolinfática	Infección bacteriana por Staphylococcus aureus	Colección purulenta tabicada por S. aureus
Lactancia Materna	Mantener lactancia a libre demanda	MANTENER LACTANCIA (¡Prohibido suspender!)	Mantener en mama sana; drenar mama afecta
Tratamiento	Calor local, masaje y vaciamiento manual	Cloxacilina o Cefadroxilo oral x 10-14 días	Drenaje quirúrgico / punción + Cloxacilina EV/oral

TRAMPAS EUNACOM

CUADRO	CUÁNDO APARECE	CONDUCTA
Congestión	Primeros días, ambas mamas	Vaciamiento y calor, sin antibióticos
Mastitis infecciosa	Segunda a cuarta semana, una mama	Cloxacilina y mantener la lactancia

REGLA DE ORO **Cesárea, el factor de riesgo** — Fiebre + útero doloroso + loquios fétidos

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **85–88** (págs. 20–21) · solucionario pág. 39.

Clase 19.19 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · PARTO PREMATURO, MECANISMO DEL PARTO, PUERPERIO & URGENCIAS OBSTÉTRICAS

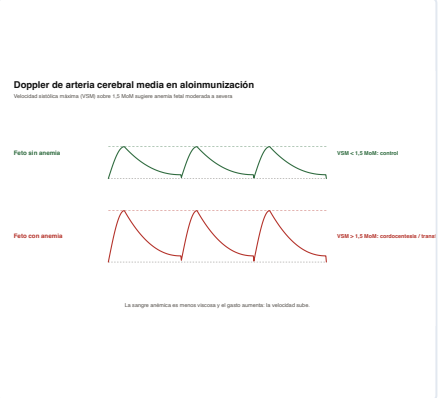
PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

19.20 Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada

3.01.3.009 **Prevención de enfermedad hemolítica perinatal** — Conocimiento general

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Incompatibilidad Rh**: Madre Rh(-) y feto Rh(+) heredado del padre biológico.
- **Test de Coombs Indirecto**: Mide anticuerpos libres en la SANGRE DE LA MADRE.
- **Test de Coombs Directo**: Mide anticuerpos adheridos en los GLÓBULOS ROJOS DEL RECIÉN NACIDO.
- **Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D (300 mcg IM)**: A las **28 semanas** y antes de **72h** postparto si el RN es Rh(+).
- ¡PROHIBIDO / INÚTIL administrar Rhogam si el Test de Coombs Indirecto ya es POSITIVO (Sensibilizada)!
- Toda paciente Rh(-) no sensibilizada debe recibir Rhogam tras aborto, ectópico, trauma o amniocentesis en < **72h**.



ARTERIA CEREBRAL MEDIA
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · ALOINMUNIZACIÓN RH: PREVENIR O VIGILAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

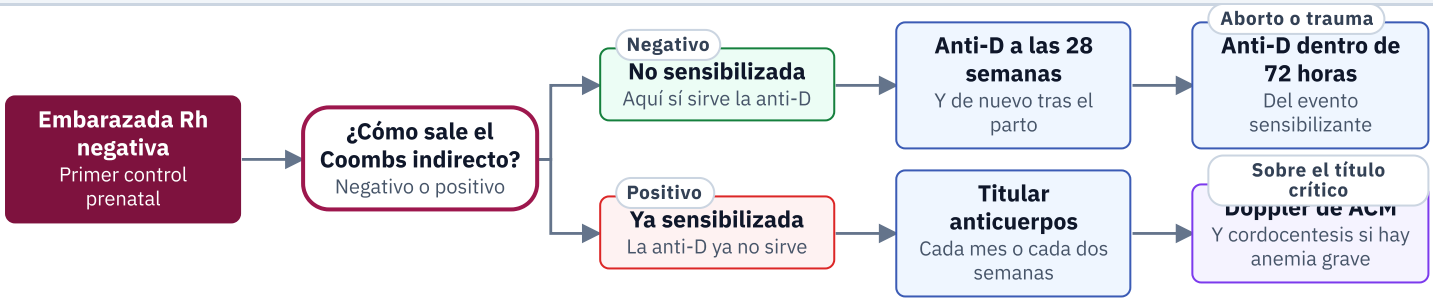


TABLA 19.20 · PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE INMUNOGLOBULINA ANTI-D (RHOGAM) EN PACIENTES RH NEGATIVAS

SITUACIÓN OBSTÉTRICA	CONDICIÓN MATERNA OBLIGATORIA	DOSIS Y VÍA	PLAZO MÁXIMO DE ADMINISTRACIÓN
Profilaxis Antenatal Rutinaria	Coombs Indirecto Negativo a las 28 semanas	300 mcg IM (1.500 UI)	A las 28 semanas cumplidas de gestación
Profilaxis Postparto Inmediata	Recién Nacido Rh Positivo y madre no sensibilizada	300 mcg IM	Dentro de las primeras 72 horas postparto (útil hasta día 28)
Aborto Espontáneo / ILE (< 12 sem)	Madre Rh negativa no sensibilizada	120 a 250 mcg IM	Dentro de las 72 horas del aborto o legrado
Aborto / Ectópico / Trauma (≥ 12 sem)	Madre Rh negativa no sensibilizada	300 mcg IM	Dentro de las 72 horas del evento clínico
Amniocentesis / Procedimiento Invasivo	Madre Rh negativa no sensibilizada	300 mcg IM	Dentro de las 72 horas post-punción
Paciente YA SENSIBILIZADA (Coombs +)	Coombs Indirecto Positivo (título > 1:4)	¡NO ADMINISTRAR RHOGAM!	Inútil; derivar a medicina materno-fetal

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

SITUACIÓN	COOMBS INDIRECTO	CONDUCTA
Control a las 28 semanas	Negativo	Dar la anti-D preventiva
Cualquier control	Positivo	Nunca dar anti-D; seguir con títulos y Doppler

REGLA DE ORO **Coombs indirecto negativo** — Anti-D a las 28 semanas y postparto

PRACTICA **Libro Gordo Obstetricia**, preguntas **89–90** (pág. 21) · solucionario pág. 40.

Clase 19.20 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 21 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · CONTROL PRENATAL & EVALUACIÓN FETAL	
19.1 Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre	pág. 3
Hb menor de **11 g/dL** — 1.er y 3.er trimestre	DOSIS
Alto riesgo de DTN — Ácido fólico **4 a 5 mg**, no **0,4 mg**	DOSIS
Hb sube **1 g/dL** en **2-3 semanas** — Control a las **4 semanas**	DOSIS
1.000 a 1.500 mg al día — Recién desde las **12 a 16 semanas**	DOSIS
19.2 Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)	pág. 4
Biometría fetal — Error de **10 a 14 días**	TIEMPO
Punción del saco amniótico — Guiada por ecografía, **15-20 mL**	DOSIS
19.3 Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal	pág. 5
Un PBF **≤ 4/**10 indica asfixia fetal severa e interrupción inmediata del embarazo.	CORTE
RBNE Reactivo: **≥ 2 aceleraciones** (aumento **≥ 15 lpm** por **≥ 15 seg**) en **20 minutos** con FCF 110-160 y variabilidad 6-25.	CORTE
La causa benigna más frecuente de RBNE no reactivo es el ciclo de sueño profundo fetal (dura **20-40 min**).	TIEMPO
19.4 Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler	pág. 6
12 mg cada **24 horas** — Dos dosis, vía intramuscular	DOSIS
Doppler seriado — Cada **24 horas** a **7 días**, según gravedad	DOSIS
Líquido Amniótico · Normal (ILA **5 a 24 cm**) · Frecuentemente oligohidramnios	CORTE
BLOQUE 02 · PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO	
19.5 Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad	pág. 7
Creatinina baja a **0,4-0,8 mg/dL** — Urea de **8 a 10 mg/dL**	DOSIS
Glucosuria benigna — Proteinuria fisiológica hasta **300 mg**	DOSIS
300 mg en orina de **24h** — O índice proteinuria-creatininuria de 0,3	DOSIS
19.6 Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio	pág. 8
Carga de 4 a 5 gramos — Endovenoso, en **20 minutos**	TIEMPO
Monitoreo estricto de magnesemia clínica: Reflejo rotuliano presente, FR **≥ 12 rpm** y diuresis **≥ 30 mL/h**.	DOSIS
Síndrome HELLP: Hemólisis (LDH > 600), Transaminasas elevadas (AST **≥ 70**) y Plaquetopenia (< 100.000).	CORTE
19.7 Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia	pág. 9
Peso estimado de **4.500 g** o más — En diabetes	DOSIS
Peso estimado de **5.000 g** o más — Sin diabetes	DOSIS
19.8 Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico	pág. 10
Ácido ursodesoxicólico — **10 a 15 mg** por kilo al día	DOSIS
Transaminasas elevadas — En **60 a 80%** de los casos	CORTE
19.9 Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda	pág. 11
Diagnóstico de BA: Urocultivo por segundo chorro con **≥ 100.000 UFC/mL** sin síntomas.	DOSIS
Antibiótico ambulatorio de 1.ª línea para BA y cistitis: Cefadroxilo oral por **7 días**.	TIEMPO
Tratamiento de pielonefritis: Cefazolina o Ceftriaxona endovenosa hasta **48h** afebril, completando **14 días** oral.	TIEMPO
19.21 Cardiopatía, Embarazo Múltiple e Hiperemesis Gravídica: Riesgo Materno, Corionicidad y Manejo Inicial	pág. 12
Marfan con raíz > **45 mm** — Coartación aórtica severa	CORTE
Vómitos incoercibles y baja de peso > **5%** — Deshidratación y cetonuria	CORTE

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
BLOQUE 03 · METRORRAGIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO	
19.10 Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030	pág. 13
Tratamiento médico de elección < **12 semanas**: Misoprostol **800 mcg** vía vaginal o sublingual.	DOSIS
Aborto completo: OCI cerrado, útero involucionado y cavidad endometrial vacía lineal (< **8-10 mm**).	CORTE
Criterio ecográfico de aborto retenido: Embrión con LCN **≥ 7 mm** SIN LCF, o saco **≥ 25 mm** sin embrión.	CORTE
Interrupción deliberada — Antes de **22 semanas** o fetos de menos de 500 gramos	TIEMPO
19.11 Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico	pág. 14
Se exige un descenso **≥ 15%** entre día 4 y día 7.	CORTE
Zona discriminatoria ecográfica de β-hCG: **1.500 a 2.000 UI**/L.	DOSIS
Criterios indispensables para Metotrexato: Paciente estable, β-hCG < **5.000 UI**/L, masa < **3.5 cm** y LCF (-).	DOSIS
Localización más frecuente del embarazo ectópico: Trompa de Falopio, región ampular (**75-80%**).	CORTE
19.12 Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento	pág. 15
Seguimiento postmolar: β-hCG semanal hasta 3 valores normales (< **5 UI**/L), luego mensual por **6 meses**.	DOSIS
Mola completa: 46XX diploide **100%** paterno, sin embrión, imagen en tormenta de nieve, β-hCG > 100.000.	CORTE
19.13 Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa	pág. 16
Cefazolina **2 g** EV, **30–60 min** antes — **3 g** si pesa **120 kg** o más	DOSIS
Realimentación a las **6–8 horas** — Alta a las **48–72 horas**	TIEMPO
Multiparidad y legrados previos — También edad materna sobre **35 años**	CORTE
Cesárea electiva a las **37 semanas** — Si sangra activo, hospitalizar ya	TIEMPO
BLOQUE 04 · PARTO PREMATURO, MECANISMO DEL PARTO, PUERPERIO & URGENCIAS OBSTÉTRICAS	
19.14 Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis	pág. 18
Betametasona, 2 dosis cada **24 horas** — O dexametasona, 4 dosis cada 12	DOSIS
34 semanas o más: se induce — Antes: corticoides y antibióticos de latencia	TIEMPO
Profilaxis si el estreptococo es positivo — O si pasan más de **12 a 18 horas**	TIEMPO
19.15 Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección	pág. 19
Nifedipino desde las **32 semanas** — Solo para ganar **48 horas**	TIEMPO
Prevención GES con Progesterona micronizada vaginal (**200 mg**/noche) ante cérvix < **25 mm** o APP previa.	DOSIS
Maduración pulmonar: Betametasona **12 mg** IM c/**24h** x 2 dosis entre 24 y **34 semanas**.	DOSIS
Cervicometría transvaginal: Corte de < **25 mm** define cérvix corto y alto riesgo de parto prematuro.	CORTE
19.16 Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento	pág. 20
Masaje uterino tras la placenta — Cada **15 minutos** por **2 horas**	TIEMPO
Score de Bishop > 6 puntos: Cuello favorable / maduro -> Se induce directamente con Oxitocina EV.	CORTE
19.17 Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)	pág. 21
Prueba de trabajo de parto — Detención de **2 horas**: cesárea	TIEMPO
Prematuridad, líquido alterado — Podálica frecuente antes de **32 semanas**	TIEMPO
Dinámica de 3 a 5 en **10 minutos** — Con monitoreo continuo y quirófano listo	TIEMPO
19.18 Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado	pág. 22
Ácido tranexámico **1 g** — Cada **8 horas**, **3 a 5 días**	DOSIS
Anticonceptivo combinado — Cada **8 horas** por **7 días**; luego uno al día	DOSIS
Definición de HPI: Pérdida **≥ 1.000 mL** o sangrado con signos de inestabilidad en las primeras **24 horas**.	DOSIS
19.19 Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)	pág. 23
Duración: Mantener antibióticos EV hasta **48 horas** afebril.	META
Antibioticoterapia de elección en endometritis: Clindamicina **900 mg** c/**8h** EV + Gentamicina **5 mg/kg**/día EV	DOSIS

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
19.20 Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada	pág. 24
A las **28 semanas** — Trescientos microgramos intramuscular	TIEMPO
De nuevo tras el parto — Antes de **72 horas**, si el hijo es Rh positivo	TIEMPO

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE	
19.1 Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre			pág. 3
Hierro oral	**100 a 200 mg de hierro elemental**	Fraccionado, lejos de las comidas	
19.2 Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)			pág. 4
Un marcador, una conducta · Doppler de uterinas alterado	**Aspirina 150 mg en la noche**	Iniciada antes de la semana 16	
19.7 Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia			pág. 9
Insulina · NPH más cristalina o análogo rápido	**La insulina no cruza la placenta**		
Insulina	**Metformina: no es primera línea**	Sí cruza la placenta	
19.9 Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda			pág. 11
Antibiótico de elección	**Cefadroxilo cada doce horas**	Por siete días completos	
Quién queda con profilaxis · Profilaxis nocturna	**Cefadroxilo o nitrofurantoína**	Una dosis nocturna hasta el parto	
19.21 Cardiopatía, Embarazo Múltiple e Hiperemesis Gravídica: Riesgo Materno, Corionicidad y Manejo Inicial			pág. 12
Fármacos, parto y puerperio · Manejo médico	**Furosemida, metoprolol, digoxina**	Evitar atenolol · reposo relativo	
Fármacos, parto y puerperio · Manejo médico	**Contraindicados: IECA, ARA II, amiodarona, estatinas**	Válvulas mecánicas: anticoagulación estricta	
Leve a moderado	**Metoclopramida, dimenhidrinato, ondansetrón**	Si no basta	
19.13 Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa			pág. 16
Perioperatorio	**Cefazolina 2 g EV, 30–60 min antes**	**3 g** si pesa **120 kg** o más	
19.14 Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis			pág. 18
La edad gestacional decide casi todo · Entre 24 y 33 más 6	**Ampicilina más eritromicina, 7 días**	Prolonga la latencia y baja la sepsis	
Antibióticos de latencia	**Ampicilina y eritromicina, 48 horas EV**	Después, la misma combinación oral	
Corticoides · Betametasona, 2 dosis cada 24 horas	**O dexametasona, 4 dosis cada 12**		
19.19 Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)			pág. 23
Antibióticos endovenosos	**Clindamicina más gentamicina**	Cubre anaerobios y bacilos gram negativos	
Mastitis infecciosa · La regla de oro	**Cloxacilina oral**	Diez a catorce días, cubre estafilococo	

GES de Obstetricia y Medicina Materno-Fetal

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

GES **GES N° 21: Prevención del Parto Prematuro (en población de riesgo con cérvix corto).**

Tema **19.15** · Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección
3.01.2.012
pág. **19**

GES **GES N° 17: Parto Prematuro / Atención Integral del Parto Respetado (Chile Crece Contigo).**

Tema **19.16** · Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento
3.01.5.010
pág. **20**

Sin garantía GES específica (19 temas): 19.1 · 19.2 · 19.3 · 19.4 · 19.5 · 19.6 · 19.7 · 19.8 · 19.9 · 19.21 · 19.10 · 19.11 · 19.12 · 19.13 · 19.14 · 19.17 · 19.18 · 19.19 · 19.20. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

4 temas · ★★★

- ★★★ **19.17** Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO) 21
- ★★★ **19.11** Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico 14
- ★★★ **19.15** Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección 19
- ★★★ **19.13** Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa 16

Practica: Libro Gordo Obstetricia, preguntas 37, 45–50, 55–60, 68–70, 73–79.

DÍA 2

4 temas · ★★★

- ★★★ **19.1** Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre 3
- ★★★ **19.9** Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda 11
- ★★★ **19.10** Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030 13
- ★★☆ **19.4** Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler 6

Practica: Libro Gordo Obstetricia, preguntas 1–4, 9–18, 38–44, 53–54.

DÍA 3

4 temas · ★★

- ★★☆ **19.6** Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio 8
- ★★☆ **19.14** Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis 18
- ★★☆ **19.5** Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad 7
- ★★☆ **19.19** Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso) 23

Practica: Libro Gordo Obstetricia, preguntas 20–28, 61–67, 85–88.

DÍA 4

3 temas · ★★

- ★★☆ **19.18** Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado 22
- ★★☆ **19.3** Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal 5
- ★☆☆ **19.2** Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría) 4

Practica: Libro Gordo Obstetricia, preguntas 5–8, 80–84.

DÍA 5

3 temas · ★

- ★☆☆ **19.7** Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia 9
- ★☆☆ **19.21** Cardiopatía, Embarazo Múltiple e Hiperemesis Gravídica: Riesgo Materno, Corionicidad y Manejo Inicial 12
- ★☆☆ **19.12** Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento 15

Practica: Libro Gordo Obstetricia, preguntas 19, 29–33, 51–52.

DÍA 6

3 temas · ★

- ★☆☆ **19.8** Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico 10
- ★☆☆ **19.16** Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento 20
- ★☆☆ **19.20** Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada 24

Practica: Libro Gordo Obstetricia, preguntas 34–36, 71–72, 89–90.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 25
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 19.1 · 19.9 · 19.10 · 19.11 · 19.13 · 19.15 · 19.17
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Obstetricia en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 7 temas

26 19.17. Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO) 21

19 19.11. Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico 14

19 19.15. Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección GES 19

18 19.13. Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa 16

17 19.1. Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre 3

16 19.9. Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda 11

16 19.10. Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030 13

★★ Prioridad media · 7 temas

12 19.4. Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler 6

12 19.6. Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio 8

12 19.14. Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis 18

11 19.5. Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad 7

11 19.19. Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso) 23

9 19.18. Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado 22

8 19.3. Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal 5

★ Prioridad baja · 7 temas

7 19.2. Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría) 4

7 19.7. Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia 9

7 19.21. Cardiopatía, Embarazo Múltiple e Hiperemesis Gravídica: Riesgo Materno, Corionicidad y Manejo Inicial 12

7 19.12. Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento 15

6 19.8. Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico 10

1 19.16. Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento GES 20

1 19.20. Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada 24